

Parasitologie Mycologie Maladies Infectieuses

I. EPREUVES

RATTRAPAGE 2025

Q1. Paludisme P

Quel est le vecteur principal du Paludisme ?

- A) Le moustique Anophèles.
- B) La mouche tsé-tsé.
- C) Le phlébotome femelle.
- D) La tique.
- E) Le triatome.

Q2. Leishmaniose

Au sein du système mononucléé phagocytaire du mammifère, Leishmania persiste sous la forme :

- A) Promastigote.
- B) Amastigote.
- C) Épimastigote.
- D) Trypomastigote.
- E) Sporozoïte.

Q3. Leishmaniose

Lors d'un repas sanguin, comment le phlébotome acquiert-il Leishmania ?

- A) En ingérant des promastigotes libres.
- B) En ingérant des macrophages contenant des amastigotes.
- C) En absorbant des sporozoïtes.
- D) En piquant directement des épimastigotes.
- E) En ingérant des érythrocytes infectés.

Q4. Leishmaniose

Quelles espèces constituent le noyau épidémiologique des leishmanioses au Maroc ?

- A) L. donovani et L. braziliensis.
- B) L. major, L. tropica et L. infantum.
- C) L. mexicana et L. guyanensis.
- D) L. amazonensis et L. peruviana.
- E) L. aethiopica et L. panamensis.

Q5. Leishmaniose

Quelle forme de leishmaniose est causée par L. major au Maroc ?

- A) Leishmaniose viscérale.
- B) Leishmaniose cutanée zoonotique.
- C) Leishmaniose cutanée anthroponotique.
- D) Leishmaniose cutanéomuqueuse.
- E) Leishmaniose dermique post-kala-azar.

Q6. Amoebose et amibes intestinales

Quelle est la forme infectieuse d'Entamoeba histolytica ?

- A) Trophozoïte.
- B) Kyste.
- C) Sporozoïte.
- D) Mérozoïte.
- E) Gamétocyte.

Q7. Amoebose et amibes intestinales

Après un repas de crudités lavées à l'eau non traitée, un voyageur développe une dysenterie amibienne. Le mode de transmission le plus probable est :

- A) Par piqûre de moustique.
- B) Par voie aérienne.
- C) Par ingestion de kystes.
- D) Par contact cutané.
- E) Par transfusion sanguine.

Q8. Amoebose et amibes intestinales

Un patient présente une dysenterie sanglante ; au microscope, on observe des amibes hématophages dans les selles fraîches. De quelle forme s'agit-il ?

- A) Kyste.
- B) Trophozoïte minuta.

- C) Trophozoïte histolytica.
- D) Métakystique.
- E) Pré-kyste.

Q9. Nématodoses digestives

Concernant le cycle d'*Ascaris lumbricoides*, cochez toutes les propositions exactes :

- A) La femelle adulte migre sous la peau.
- B) La larve migre à travers le poumon avant de regagner l'intestin.
- C) Les vers adultes poursuivent leur cycle dans le milieu extérieur.
- D) La parasitose est transmise par voie orale.
- E) C'est un cycle hétéroxène.

Q10. Nématodoses digestives

Quel nématode est l'agent causal de l'oxyurose ?

- A) *Ascaris lumbricoides*.
- B) *Enterobius vermicularis*.
- C) *Trichuris trichiura*.
- D) *Necator americanus*.
- E) *Ancylostoma duodenale*.

Q11. Nématodoses digestives

Comment se transmet le plus souvent *Enterobius vermicularis* ?

- A) Par piqure de moustique.
- B) Par ingestion d'oeufs.
- C) Par contact cutané avec des larves.
- D) Par voie sexuelle.
- E) Par transfusion sanguine.

Q12. Nématodoses digestives

La nuit, les femelles d'oxyures migrent pour pondre leurs oeufs :

- A) Dans l'estomac.
- B) Dans l'intestin grêle.
- C) Dans le côlon.
- D) Dans la région péri-anale.
- E) Dans les poumons.

Q13. Nématodoses digestives

Quelle est la méthode de diagnostic la plus couramment utilisée pour l'oxyurose ?

- A) Analyse de sang.
- B) Test du scotch (Scotch tape test).
- C) Radiographie abdominale.
- D) Échographie intestinale.
- E) Test PCR sur selles.

Q14. Némathelminthes

Quel nématode est l'agent causal de l'anguillulose (strongyloïdose) ?

- A) *Ascaris lumbricoides*.
- B) *Enterobius vermicularis*.
- C) *Strongyloides stercoralis*.
- D) *Necator americanus*.
- E) *Trichuris trichiura*.

Q15. Némathelminthes

Quel est le mode de contamination habituel par *Strongyloides stercoralis* ?

- A) Par ingestion d'oeufs.
- B) Par piqure de moustique.
- C) Par passage transcutané des larves infestantes.
- D) Par voie sexuelle.
- E) Par transfusion sanguine.

Q16. Introduction à la parasitologie médicale

Dans l'anguillulose chronique, le profil d'éosinophilie le plus caractéristique est :

- A) Absence d'éosinophilie.
- B) Éosinophilie constante et élevée.
- C) Éosinophilie en "dents de scie" ou fluctuante.
- D) Éosinophilie uniquement en phase aiguë.
- E) Éosinophilie uniquement en phase de guérison.

Q17. Némathelminthes

Chez un patient immunodéprimé atteint de strongyloïdose, la complication la plus redoutée est :

- A) Hémorragie digestive.
- B) Anguillulose maligne ou invasive.
- C) Occlusion intestinale.

- D) Pancréatite aiguë.
- E) Méningite.

Q18. Plathelminthes

Après un barbecue, un patient ayant mangé du porc rosé élimine des anneaux blanchâtres dans les selles. Le mode d'acquisition le plus probable est :

- A) En ingérant des oeufs du parasite.
- B) En ingérant de la viande de porc contaminée insuffisamment cuite.
- C) Par contact cutané avec des larves.
- D) Par piqûre d'insecte.
- E) En buvant de l'eau contaminée.

Q19. Hydatidose

Dans le cycle d'E. granulosus, le ver adulte se développe et pond des oeufs dans l'intestin de :

- A) Les chiens sont l'hôte définitif d'Echinococcus granulosus.
- B) Les bovins sont l'hôte définitif d'Echinococcus granulosus.
- C) Les ovins sont l'hôte définitif d'Echinococcus granulosus.
- D) Les humains sont l'hôte définitif d'Echinococcus granulosus.
- E) Les souris sont l'hôte définitif d'Echinococcus granulosus.

Q20. Hydatidose

Quel est le mode de contamination le plus fréquent chez l'homme pour Echinococcus granulosus ?

- A) Les piqûres d'insectes.
- B) L'ingestion de viande insuffisamment cuite.
- C) Marcher pieds nus dans un sol boueux.
- D) L'ingestion d'aliments contaminés par des oeufs du parasite.
- E) L'inhalation des oeufs du parasite.

Q21. Plathelminthes

Quel est l'hôte intermédiaire de Taenia saginata ?

- A) Chat.
- B) Porc.
- C) Boeuf.
- D) Caprin.
- E) Équidé.

Q22. Plathelminthes

Quel examen apporte la preuve parasitologique formelle d'un Bothriocephalus/Diphyllobothrium ?

- A) Mise en évidence d'oeufs à l'EPS.
- B) Présence de symptômes gastro-intestinaux sévères.
- C) Identification d'anneaux extériorisés.
- D) Mise en culture des selles.
- E) Analyse sanguine pour hyper-éosinophilie.

Q23. Introduction à la parasitologie médicale

Quelle complication est associée à la bilharziose uro-génitale ?

- A) Hématurie indolore.
- B) Calcification vésicale.
- C) Pneumonie.
- D) Diabète.
- E) Hypertension.

Q24. Introduction à la parasitologie médicale

Qu'est-ce qu'un parasite ?

- A) Un organisme qui vit en symbiose mutuelle avec son hôte.
- B) Un organisme qui vit aux dépens d'un autre organisme sans le détruire complètement.
- C) Un prédateur qui tue sa proie pour se nourrir.
- D) Un organisme qui vit de manière indépendante dans l'environnement.
- E) Un organisme qui décompose la matière organique morte.

Q25. Introduction à la mycologie

En mycologie médicale, une mycose désigne :

- A) Les infections virales.
- B) Les lésions provoquées par des champignons microscopiques.
- C) Les infections bactériennes.
- D) Les états inflammatoires des tissus.
- E) Les lésions provoquées par des champignons macroscopiques.

Q26. Méningites infectieuses

Cas Clinique (Q26, Q27, Q28, Q29, Q30) : Mr M.H âgé de 16 ans, sans antécédents particuliers, est hospitalisé pour une altération de l'état de conscience avec épisodes d'hallucinations visuelles et auditives. Sa famille rapporte une fièvre à 38,7°C évoluant depuis 4 jours avec des épisodes de confusion et des crises convulsives partielles. Quel est l'examen complémentaire à réaliser en première intention ?

- A) Dosage des anticorps anti-HSV dans le sang.
- B) Ponction lombaire avec analyse du LCR.
- C) Électroencéphalogramme.
- D) IRM cérébrale.
- E) Scanner cérébral sans injection.

Q27. Méningites infectieuses

Quel est le principal agent causal de cette encéphalite ?

- A) Entérovirus.
- B) Virus varicelle-zona (VZV).
- C) Virus de la rage.
- D) Virus de l'herpès simplex type 1 (HSV-1).
- E) Mycobacterium tuberculosis.

Q28. Méningites infectieuses

Quel signe clinique est particulièrement évocateur d'une encéphalite herpétique ?

- A) Syndrome méningé isolé.
- B) Syndrome pyramidal pur.
- C) Diplopie et syndrome cérébelleux.
- D) Hémiparésie isolée.
- E) Signes temporaux : troubles mnésiques, hallucinations, crises épileptiques focales.

Q29. Méningites infectieuses

Quelle est la complication la plus redoutée ?

- A) Syndrome de Guillain-Barré.
- B) Hydrocéphalie.
- C) OEdème cérébral et engagement temporal.
- D) Abscès cérébral.
- E) Méningite purulente secondaire.

Q30. Méningites infectieuses

Quelle est la durée recommandée du traitement par l'Aciclovir IV ?

- A) 14 à 21 jours.
- B) 7 jours.
- C) 10 jours.
- D) 5 jours.
- E) 30 jours.

Q31. Infection à VIH

Quelles sont les indications obligatoires de la sérologie VIH ?

- A) Bilan préopératoire.
- B) Bilan d'amaigrissement.
- C) Don de sang.
- D) Accident d'exposition au sang.
- E) Don d'organe.

Q32. AES

En cas d'accident d'exposition au sang :

? Patient source : Ag HBs +, Ac anti HVC -, Ac Anti VIH -

? Patient victime : Age 40 ans, vacciné contre l'hépatite B avec Ac anti Hbc à 5 UI/mm.

Quelle est votre attitude prophylactique ?

- A) Surveiller les transaminases.
- B) Démarrer la prophylaxie antirétrovirale.
- C) Donner une antibioprophylaxie.
- D) Vacciner la victime contre l'hépatite virale B.
- E) Aucune réponse n'est juste.

Q33. AES

En cas d'accident d'exposition au sang, quelle (s) est (sont) la (les) mesures de protection vis-à-vis du risque VHC ?

- A) Il n'existe pas de prophylaxie vis-à-vis du risque VHC.
- B) Vaccination anti VHC.
- C) Administrations d'immunoglobulines spécifiques.
- D) Traitement antiviral post exposition.
- E) Traitement immunomodulateur prophylactique par interféron pégylé.

Q34. Infection à VIH

Cas clinique (Q34, Q35, Q36, Q37, Q38) : Homme de 35 ans, suivi pour VIH non contrôlé, se présente aux urgences pour une dyspnée progressive associée à une toux sèche et une fièvre persistante depuis 3 semaines. Il a perdu 7 kg en 2 mois et rapporte une asthénie majeure. Aucun traitement antirétroviral ni prophylaxie n'est en cours. À l'examen : Température : 38,9 °C, FR : 28/min, SpO2 : 90 % à l'air ambiant, Râles crépitants bilatéraux diffus. Pas d'adénopathies palpables, absence de signes méningés. Radiographie thoracique : infiltrats bilatéraux interstitiels diffus sans épanchement pleural. Scanner thoracique : opacités en verre dépoli prédominant dans les lobes inférieurs. Examens biologiques : CD4 : 35/mm3, LDH : 880 UI/L (N < 250), Hb = 8 g/dl. Quels sont les diagnostics les plus probables ?

- A) Pneumocystose pulmonaire.
- B) Sarcoidose stade II.
- C) Pneumonie bactérienne à germes atypiques.
- D) Miliaire tuberculeuse.
- E) Alvéolite allergique extrinsèque.

Q35. Infection à VIH

Quelles anomalies biologiques typiques d'une pneumocystose pulmonaire ?

- A) Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles.
- B) Anémie hypochrome microcytaire.
- C) Hyponatrémie.
- D) LDH élevé.
- E) Hyponatrémie.

Q36. Infection à VIH

Quelle est la méthode diagnostique de choix pour confirmer une pneumocystose ?

- A) Hémocultures standards.
- B) Recherche de *Pneumocystis jirovecii* sur liquide broncho-alvéolaire (LBA).
- C) Culture d'expectorations sur milieu spécifique.
- D) Recherche des antigènes fongiques dans le sang.
- E) Biopsie pulmonaire chirurgicale.

Q37. Infection à VIH

Quel est le traitement de première intention pour une pneumocystose ?

- A) Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide + Ethambutol (RIP/RHE).
- B) Fluconazole à forte dose.
- C) Amphotéricine B liposomale.
- D) Cotrimoxazole (TMP-SMX) à forte dose + corticothérapie.
- E) Ciprofloxacine associée à un macrolide.

Q38. Infection à VIH

Quels sont les facteurs de risque spécifiques d'une pneumocystose pulmonaire chez les patients immunodéprimés ?

- A) Traitement par corticostéroïdes prolongé.
- B) Taux de CD4 < 200/mm³ chez les patients VIH.
- C) Absence de prophylaxie par cotrimoxazole chez un patient à risque.
- D) Co-infection par *Aspergillus fumigatus*.
- E) Réactivation d'un foyer pulmonaire ancien de *Pneumocystis jirovecii*.

Q39. Paludisme MI

Concernant le paludisme, quelles sont les propositions exactes ?

- A) Le vecteur du parasite est l'anophèle femelle.
- B) On connaît actuellement 5 espèces plasmodiales.
- C) Le réservoir de l'hématozoaire du genre *plasmodium* est humain.
- D) Le paludisme est une protozoose.
- E) La majorité des cas mondiaux est due à *plasmodium malariae*.

Q40. Paludisme MI

Les signes biologiques classiques au cours d'un accès palustre sont :

- A) Hyperleucocytose.
- B) Anémie hémolytique.
- C) Thrombopénie.
- D) Cytolyse hépatique.
- E) Hyperéosinophilie.

Q41. Septicémies à staphylocoques

En cas d'endocardite infectieuse à staphylocoque méthi-sensible, quel schéma thérapeutique vous proposez en première intention ?

- A) Céphalosporine de 3ème génération, pendant 6 semaines.
- B) Vancomycine + Gentamycine, pendant 2 semaines.
- C) Céphalosporine de 3ème génération, pendant 2 semaines.
- D) Céphalosporine de 3ème génération + Gentamycine, pendant 2 semaines.
- E) Céphalosporine de 3ème génération + Gentamycine, pendant 6 semaines.

Q42. Infections à streptocoques

Cas clinique (42,43,44) : Vous recevez une femme de 72 ans diabétique type 2 sous metformine et HTA sous amlodipine pour une douleur fébrile de la jambe droite évoluant depuis 24h. L'examen clinique montre une température 39.3 et TA 140/70mmHg FC 100/min, placard oedémateux rouge chaud induré douloureux bien limité de la jambe droite avec aspect érosif et macéré des 2 derniers espaces inter digitaux plantaire des 2 pieds. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Fasciite nécrosante.
- B) Ecthyma.
- C) Dermohypodermite bactérienne non nécrosante.
- D) Syndrome de Stevens-Johnson.
- E) Thrombose veineuse profonde.

Q43. Infections à streptocoques

Quel est le germe le plus probable ?

- A) Staphylococcus à coagulase négative.
- B) Escherichia coli entérohémorragique EHEC.
- C) Staphylococcus Aureus.
- D) Streptococcus pyogenes.
- E) Streptococcus Agalactiae.

Q44. Infections à streptocoques

Quels sont les 2 antibiotiques de 1ère intention ?

- A) Pénicilline G.
- B) Pristinamycine.
- C) Amoxicilline.
- D) Pénicilline M.
- E) Amoxicilline-acide clavulanique.

Q45. Leptospirose

Parmi les éléments suivants, indiquez celui ou ceux qui vous paraît (paraissent) évocateurs de la leptospirose ?

- A) Thrombopénie.
- B) Insuffisance rénale.
- C) Hyperleucocytose.
- D) Méningite purulente à la ponction lombaire.
- E) Ictère.

Q46. Leptospirose

Parmi les examens complémentaires suivants lequel permet de poser en routine le diagnostic de la leptospirose ?

- A) L'hémoculture.
- B) Le Test d'agglutination microscopique (MAT).
- C) Le Western blot.
- D) La bandelette urinaire.
- E) L'antigénémie.

Q47. TIAC

Concernant la symptomatologie habituelle de la toxi-infection alimentaire à Salmonelle de l'adulte jeune, reprenez les faits exacts :

- A) Syndrome dysentérique.
- B) Incubation courte < 12 heures de l'ingestion de l'aliment.
- C) Vomissements.
- D) Hyperthermie.
- E) Diarrhée cholériforme.

Q48. Infection à VIH

Le diagnostic de la co-infection VIH - Tuberculose au stade avancé de l'immunodépression repose sur :

- A) Le Quantiferon -TB.
- B) L'intradermoréaction à la tuberculine.
- C) Le gene-xpert dans les expectorations.
- D) Biopsie ganglionnaire.
- E) L'isolement de BK dans les expectorations.

Q49. Infection à VIH

Indiquez-la ou les propositions exactes concernant le gancyclovir (Cymevan®):

- A) Il agit sur les herpès simplex virus de type 1 et 2 et sur le cytomégalovirus.
- B) Il agit par inhibition de la synthèse de l'ADN viral.
- C) Nécessite la surveillance du taux des polynucléaires neutrophiles.
- D) C'est le traitement de référence de la méningo-encéphalite herpétique.
- E) Indiqué dans l'oesophagite à cytomégalovirus.

Q50. Antibiotiques

Les céphalosporines de troisième génération sont :

- A) Toutes actives sur Pseudomonas aeruginosa.
- B) Actifs sur les entérobactéries.
- C) Des betalactamines.
- D) Indiquées dans l'endocardite bactérienne.
- E) Indiquées dans la méningite à Listeria.

NORMALE 2025

Q51. Leishmaniose

Quel est le vecteur principal de la leishmaniose ?

- A) Le moustique Anophèles.
- B) La mouche tsé-tsé.
- C) Le phlébotome femelle.

- D) La tique.
- E) Le triatome.

Q52. Leishmaniose

Sous quelle forme le parasite *Leishmania* est-il présent dans les cellules de l'hôte mammifère ?

- A) Promastigote.
- B) Amastigote.
- C) Épimastigote.
- D) Trypomastigote.
- E) Sporozoïte.

Q53. Leishmaniose

Comment le vecteur s'infecte-t-il lors d'un repas sanguin sur un hôte infecté ?

- A) En ingérant des promastigotes libres.
- B) En ingérant des macrophages contenant des amastigotes.
- C) En absorbant des sporozoïtes.
- D) En piquant directement des épimastigotes.
- E) En ingérant des érythrocytes infectés.

Q54. Leishmaniose

Quelles sont les principales espèces de *Leishmania* responsables des leishmanioses au Maroc ?

- A) *L. donovani* et *L. braziliensis*.
- B) *L. major*, *L. tropica* et *L. infantum*.
- C) *L. mexicana* et *L. guyanensis*.
- D) *L. amazonensis* et *L. peruviana*.
- E) *L. aethiopica* et *L. panamensis*.

Q55. Leishmaniose

Quelle forme de leishmaniose est causée par *L. major* au Maroc ?

- A) Leishmaniose viscérale.
- B) Leishmaniose cutanée zoonotique.
- C) Leishmaniose cutanée anthroponotique.
- D) Leishmaniose cutanéomuqueuse.
- E) Leishmaniose dermique post-kala-azar.

Q56. Amoebose et amibes intestinales

Quelle est la forme infectieuse d'*Entamoeba histolytica* ?

- A) Trophozoïte.
- B) Kyste.
- C) Sporozoïte.
- D) Mérozoïte.
- E) Gamétocyte.

Q57. Amoebose et amibes intestinales

Comment se fait principalement la transmission de l'amibiose ?

- A) Par piqûre de moustique.
- B) Par voie aérienne.
- C) Par ingestion de kystes.
- D) Par contact cutané.
- E) Par transfusion sanguine.

Q58. Amoebose et amibes intestinales

Quelle forme d'*Entamoeba histolytica* est responsable de l'amibiase maladie ?

- A) Kyste.
- B) Trophozoïte minuta.
- C) Trophozoïte histolytica.
- D) Métakystique.
- E) Pré-kyste.

Q59. Nématodoses digestives

Concernant le cycle d'*Ascaris lumbricoides* :

- A) La femelle adulte migre sous la peau.
- B) La larve migre à travers le poumon avant de regagner l'intestin.
- C) Les vers adultes poursuivent leur cycle dans le milieu extérieur.
- D) La parasitose est transmise par voie orale.
- E) C'est un cycle hétéroxène.

Q60. Nématodoses digestives

Quel est l'agent responsable de l'oxyurose ?

- A) *Ascaris lumbricoides*.
- B) *Enterobius vermicularis*.
- C) *Trichuris trichiura*.
- D) *Necator americanus*.

E) Ancylostoma duodenale.

Q61. Nématodoses digestives

Comment se fait principalement la transmission de l'oxyurose ?

- A) Par piquûre de moustique.
- B) Par ingestion d'oeufs.
- C) Par contact cutané avec des larves.
- D) Par voie sexuelle.
- E) Par transfusion sanguine.

Q62. Nématodoses digestives

Où les femelles d'oxyures pondent-elles leurs oeufs ?

- A) Dans l'estomac.
- B) Dans l'intestin grêle.
- C) Dans le côlon.
- D) Dans la région péri-anale.
- E) Dans les poumons.

Q63. Nématodoses digestives

Quelle est la méthode de diagnostic la plus couramment utilisée pour l'oxyurose ?

- A) Analyse de sang.
- B) Test du scotch (Scotch tape test).
- C) Radiographie abdominale.
- D) Échographie intestinale.
- E) Test PCR sur selles.

Q64. Némathelminthes

Quel est l'agent responsable de l'anguillulose ?

- A) Ascaris lumbricoides.
- B) Enterobius vermicularis.
- C) Strongyloides stercoralis.
- D) Necator americanus.
- E) Trichuris trichiura.

Q65. Némathelminthes

Quel est le mode de transmission principal de l'anguillulose ?

- A) Par ingestion d'oeufs.
- B) Par piquûre de moustique.
- C) Par passage transcutané des larves infestantes.
- D) Par voie sexuelle.
- E) Par transfusion sanguine.

Q66. Introduction à la parasitologie médicale

Quelle caractéristique de l'éosinophilie sanguine est typique de l'anguillulose chronique ?

- A) Absence d'éosinophilie.
- B) Éosinophilie constante et élevée.
- C) Éosinophilie en "dents de scie" ou fluctuante.
- D) Éosinophilie uniquement en phase aiguë.
- E) Éosinophilie uniquement en phase de guérison.

Q67. Némathelminthes

Quelle complication majeure peut survenir chez les patients immunodéprimés atteints d'anguillulose ?

- A) Hémorragie digestive.
- B) Anguillulose maligne ou invasive.
- C) Occlusion intestinale.
- D) Pancréatite aiguë.
- E) Méningite.

Q68. Plathelminthes

Comment l'homme s'infecte-t-il par le ténia adulte Taenia solium ?

- A) En ingérant des oeufs du parasite.
- B) En ingérant de la viande de porc contaminée insuffisamment cuite.
- C) Par contact cutané avec des larves.
- D) Par piquûre d'insecte.
- E) En buvant de l'eau contaminée.

Q69. Hydatidose

Quel est l'hôte définitif d'Echinococcus granulosus :

- A) Les chiens sont l'hôte définitif d'Echinococcus granulosus.
- B) Les bovins sont l'hôte définitif d'Echinococcus granulosus.
- C) Les ovins sont l'hôte définitif d'Echinococcus granulosus.
- D) Les humains sont l'hôte définitif d'Echinococcus granulosus.
- E) Les souris sont l'hôte définitif d'Echinococcus granulosus.

Q70. Hydatidose

Par quel moyen les humains sont-ils généralement infectés par *Echinococcus granulosus* :

- A) Les piqûres d'insectes.
- B) L'ingestion de viande insuffisamment cuite.
- C) Marcher pieds nus dans un sol boueux.
- D) L'ingestion d'aliments contaminés par des oeufs du parasite.
- E) L'inhalation des oeufs du parasite.

Q71. Plathelminthes

Quel est l'hôte intermédiaire de *Taenia saginata* ?

- A) Chat.
- B) Porc.
- C) Boeuf.
- D) Caprin.
- E) Équidé.

Q72. Plathelminthes

Quel est le critère de certitude pour établir un diagnostic de *Bothriocéphale* ?

- A) Mise en évidence d'oeufs à l'EPS.
- B) Présence de symptômes gastro-intestinaux sévères.
- C) Identification d'anneaux extériorisés.
- D) Mise en culture des selles.
- E) Analyse sanguine pour hyper-éosinophilie.

Q73. Introduction à la parasitologie médicale

Quelle complication est associée à la bilharziose uro-génitale ?

- A) Hématurie indolore.
- B) Calcification vésicale.
- C) Pneumonie.
- D) Diabète.
- E) Hypertension.

Q74. Introduction à la parasitologie médicale

Qu'est-ce qu'un parasite ?

- A) Un organisme qui vit en symbiose mutuelle avec son hôte.
- B) Un organisme qui vit aux dépens d'un autre organisme sans le détruire complètement.
- C) Un prédateur qui tue sa proie pour se nourrir.
- D) Un organisme qui vit de manière indépendante dans l'environnement.
- E) Un organisme qui décompose la matière organique morte.

Q75. Introduction à la mycologie

Que désigne le terme « Mycose » en mycologie médicale ?

- A) Les infections virales.
- B) Les lésions provoquées par des champignons microscopiques.
- C) Les infections bactériennes.
- D) Les états inflammatoires des tissus.
- E) Les lésions provoquées par des champignons macroscopiques.

Q76. Méningites infectieuses

Cas clinique : Mr M.H âgé de 16 ans, sans antécédents particuliers, est hospitalisé pour une altération de l'état de conscience avec épisodes d'hallucinations visuelles et auditives. Sa famille rapporte une fièvre à 38,7°C évoluant depuis 4 jours avec des épisodes de confusion et des crises convulsives partielles. Quel est l'examen complémentaire à réaliser en première intention ?

- A) Scanner cérébral sans injection.
- B) Ponction lombaire avec analyse du LCR.
- C) IRM cérébrale.
- D) Dosage des anticorps anti-HSV dans le sang.
- E) Électroencéphalogramme.

Q77. Méningites infectieuses

Quel est le principal agent causal de cette encéphalite ?

- A) Virus de l'herpès simplex type 1 (HSV-1).
- B) Virus varicelle-zona (VZV).
- C) Virus de la rage.
- D) Entérovirus.
- E) *Mycobacterium tuberculosis*.

Q78. Méningites infectieuses

Quel signe clinique est particulièrement évocateur d'une encéphalite herpétique ?

- A) Syndrome méningé isolé.
- B) Syndrome pyramidal pur.
- C) Signes temporaux : troubles mnésiques, hallucinations, crises épileptiques focales.
- D) Hémiparésie isolée.
- E) Diplopie et syndrome cérébelleux.

Q79. Méningites infectieuses

Quelle est la complication la plus redoutée ?

- A) Hydrocéphalie.
- B) Syndrome de Guillain-Barré.
- C) Oedème cérébral et engagement temporal.
- D) Abscess cérébral.
- E) Méningite purulente secondaire.

Q80. Méningites infectieuses

Quelle est la durée recommandée du traitement par l'Aciclovir IV ?

- A) 5 jours.
- B) 7 jours.
- C) 10 jours.
- D) 14 à 21 jours.
- E) 30 jours.

Q81. Infections liées aux tiques

Cas clinique : Mr R.G 72 ans, diabétique de type 2, est hospitalisé pour un syndrome fébrile aigu évoluant depuis 6 jours. Il présente des céphalées, des myalgies diffuses, une altération de l'état général et des douleurs articulaires. L'examen clinique retrouve une éruption maculopapuleuse diffuse, atteignant également la paume des mains et la plante des pieds, ainsi qu'une escarre noirâtre sur la face postérieure du mollet droit, des taches purpuriques et début d'ischémie du membre. Il a une hypotension artérielle à 95/60 mmHg, une polypnée à 24 cycles/min et des conjonctives subictériques. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Leptospirose ictéro-hémorragique.
- B) Méningococcémie.
- C) Fièvre boutonneuse méditerranéenne compliquée.
- D) Endocardite infectieuse.
- E) Syphilis secondaire.

Q82. Infections liées aux tiques

Quels sont les examens diagnostiques de confirmation à réaliser ?

- A) Sérologie IgM/IgG anti-Rickettsia conorii.
- B) PCR sur biopsie de l'escarre.
- C) Hémocultures.
- D) Test de micro-agglutination pour la leptospirose.
- E) Culture bactérienne sur gélose chocolat.

Q83. Infections liées aux tiques

Quels sont les critères de gravités chez ce patient ?

- A) Hypotension artérielle.
- B) Atteinte multi-organique.
- C) Insuffisance rénale.
- D) Ischémie du membre.
- E) Escarre d'inoculation.

Q84. Infections liées aux tiques

Quelle est la prise en charge thérapeutique adaptée ?

- A) Doxycycline IV.
- B) Ceftriaxone IV.
- C) Amoxicilline-clavulanate.
- D) Gentamycine.
- E) Azithromycine.

Q85. Infections liées aux tiques

Quelles mesures de prévention recommander à ce patient pour éviter une infection ?

- A) Port de vêtements longs lors des randonnées en zones endémiques.
- B) Utilisation de répulsifs anti-tiques.
- C) Surveillance de l'apparition d'une fièvre après contact avec des chiens.
- D) Vaccination contre la fièvre boutonneuse méditerranéenne.
- E) Administration prophylactique de doxycycline après exposition à une morsure de tique.

Q86. Infection à VIH

Cas clinique : Un homme de 35 ans, asthmatique, suivi pour VIH non contrôlé, se présente aux urgences pour une dyspnée progressive associée à une toux sèche et une fièvre persistante depuis 3 semaines. Il a perdu 7 kg en 2 mois et rapporte une asthénie majeure. Aucun traitement antirétroviral ni prophylaxie n'est en cours. À l'examen : Température à 38,9 °C, FR à 28/min, SpO2 à 90 % à l'air ambiant, Râles crépitants bilatéraux diffus. Radiographie thoracique : infiltrats bilatéraux interstitiels diffus. Scanner thoracique : opacités en verre dépoli bilatérales prédominant dans les lobes inférieurs. Les examens biologiques montrent : CD4:35/mm³, LDH :880 UI/L (N : 250), Hb = 8 g/dl. Quels sont les diagnostics les plus probables ?

- A) Pneumocystose pulmonaire.
- B) Miliare tuberculeuse.
- C) Pneumonie bactérienne.
- D) Décompensation d'asthme.
- E) Pleurésie tuberculeuse.

Q87. Infection à VIH

Quelles anomalies biologiques typiques d'une pneumocystose pulmonaire ?

- A) LDH élevés.
- B) Anémie hypochrome microcytaire.
- C) Hypoxémie.
- D) Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles.
- E) Hyponatrémie.

Q88. Infection à VIH

Quelle est la méthode diagnostique de choix pour confirmer une pneumocystose ?

- A) Biopsie pulmonaire chirurgicale.
- B) Recherche de *Pneumocystis jirovecii* sur liquide broncho-alvéolaire (LBA).
- C) Hémocultures standard.
- D) Recherche des antigènes fongiques dans le sang.
- E) Culture d'expectorations sur milieu spécifique.

Q89. Infection à VIH

Quel est le traitement de première intention pour une pneumocystose ?

- A) Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide + Ethambutol (RIP/RHE).
- B) Cotrimoxazole (TMP-SMX) à forte dose + corticothérapie.
- C) Amphotéricine B liposomale.
- D) Fluconazole à forte dose.
- E) Ciprofloxacine associée à un macrolide.

Q90. Infection à VIH

Cas Clinique : Un homme de 40 ans, porteur du VIH depuis 7 ans, se présente aux urgences pour des céphalées intenses, des épisodes de confusion, et une faiblesse progressive de l'hémicorps gauche depuis 10 jours. Il est en échec thérapeutique avec un taux de CD4 à 45/mm² et une charge virale à 250 000 copies/mL. Il n'a pas de prophylaxie anti-toxoplasmique en cours. À l'examen : Température : 38,3 °C ; Désorientation temporelle, Babinski bilatéral ; Pas de raideur méningée ni d'éruption cutanée. Les examens complémentaires révèlent : IRM cérébrale : lésions multiples nodulaires, rehaussées en anneau après contraste, avec oedème périlésionnel marqué. Quels sont les diagnostics à évoquer ?

- A) Lymphome cérébral primitif.
- B) Méningite cryptococcique.
- C) Abscès cérébraux bactériens.
- D) Encéphalite herpétique.
- E) Toxoplasmose cérébrale.

Q91. Infection à VIH

Quelle est votre conduite à tenir ?

- A) Initiation d'un traitement par Triméthoprim+Sulfaméthoxazole.
- B) Biopsie cérébrale immédiate.
- C) Corticothérapie à forte dose pour réduire l'oedème péri lésionnel.
- D) Administration de Cotrimoxazole prophylactique.
- E) Démarrage d'un traitement anticonvulsivant.

Q92. Infection à VIH

Parmi ces éléments, lesquels permettront de confirmer une toxoplasmose cérébrale ?

- A) Bonne évolution sous traitement anti *Toxoplasma gondii*.
- B) Présence d'IgG *Toxoplasma gondii*.
- C) Lésions unifocales en IRM.
- D) Absence de fièvre.
- E) CD4 < 200/mm³.

Q93. Infection à VIH

Quelle est la durée minimale recommandée pour le traitement curatif complet de la toxoplasmose cérébrale ?

- A) 7 jours.
- B) 2 semaines.
- C) 6 semaines.
- D) 3 mois.
- E) Indéfiniment.

Q94. Paludisme MI

Cas clinique : Un jeune de 29 ans, sans ATCDs, s'est présenté aux urgences pour une fièvre d'installation brutale, arthromyalgies et céphalées évoluant depuis 3 jours sans autres signes fonctionnels associés. À l'examen physique : Un état général conservé, Température : 39°C et pas d'éruption cutanée. À ce stade quels sont les diagnostics à évoquer ?

- A) Primo-infection à VIH.
- B) Leptospirose.
- C) Paludisme.
- D) Fièvre boutonneuse méditerranéenne.
- E) Fièvre typhoïde.

Q95. Paludisme MI

Quels autres éléments de l'interrogatoire recherchez-vous pour affiner votre diagnostic ?

- A) Profession.
- B) Retour de voyage.
- C) Rapports sexuels non protégés.
- D) Animaux dans l'entourage.
- E) Pique d'insectes.

Q96. Leptospirose

Le patient a été traité par du paracétamol et il est rentré chez lui, deux jours plus tard, le patient reconsulte aux urgences pour persistance de la fièvre, des céphalées, l'apparition d'un ictère cutanéomuqueux généralisé. Biologie : GB : 3500 éléments/mm³, Hb : 12g/dl, Plq : 85 000 éléments/mm³, insuffisance rénale. Quel est votre diagnostic ?

- A) Primo-infection à VIH.
- B) Leptospirose.
- C) Paludisme.
- D) Fièvre boutonneuse méditerranéenne.
- E) Fièvre typhoïde.

Q97. Leptospirose

Pour confirmer ce diagnostic vous allez compléter par :

- A) Hémocultures.
- B) Sérologie des rickettsioses.
- C) Western Blot.
- D) Goutte épaisse et frottis mince.
- E) Sérologie de leptospirose par micro-agglutination.

Q98. Leptospirose

Quel traitement prescrivez-vous ?

- A) Doxycycline 200mg/jour.
- B) Réhydratation.
- C) Céphalosporine de 3ème génération.
- D) Chloroquine.
- E) Artéméter-luméfantrine.

Q99. Infection à VIH

Quelles sont les indications obligatoires de la sérologie VIH ?

- A) Don de sang.
- B) Don d'organe.
- C) Bilan préopératoire.
- D) Accident d'exposition au sang.
- E) Bilan de grossesse.

Q100. AES

En cas d'accident d'exposition au sang : Patient source : Ag Hbs +, Ac anti HVC -, Ac Anti VIH -. Patient victime : Age 40 ans, vacciné contre l'hépatite B avec Ac anti Hbc à 5 UI/mm. Quelle est votre attitude prophylactique ?

- A) Surveiller les transaminases.
- B) Démarrer la prophylaxie antirétrovirale.
- C) Vacciner la victime contre l'hépatite virale B.
- D) Donner une antibioprophylaxie.
- E) Aucune réponse.

NOVEMBRE 2024 (NORMALE)

Q101. Méningites infectieuses

Une méningite à liquide purulent peut être causée par une infection à :

- A) Streptococcus pneumoniae.
- B) Mycobacterium tuberculosis.
- C) Herpes simplex virus.
- D) Neisseria meningitidis.
- E) Listeria monocytogenes.

Q102. Méningites infectieuses

Les arguments en faveur d'une méningo-encéphalite tuberculeuse comportent :

- A) Hypoglycorachie.
- B) Trouble du comportement.
- C) Présence de globules rouges dans le LCR.
- D) Immunodépression.
- E) Atteinte des paires crâniennes.

Q103. Méningites infectieuses

Vous recevez aux urgences une femme de 25 ans pour un syndrome méningé fébrile. Elle n'a pas d'antécédent notable. Elle présente depuis 3 jours une pharyngite sans amygdalite, avec une fièvre à 38,6°C. L'examen physique à l'arrivée montre : T= 39°, FC= 100/min, PA= 100/60 mm Hg, FR=16 cycles/min ; Somnolence, obnubilation ; Macules violacées ne s'effaçant pas à la vitro

pression ; Raideur méningée. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Méningite à Méningocoque.
- B) Méningite à Pneumocoque.
- C) Méningite Virale.
- D) Méningite Tuberculeuse.
- E) Méningite Listérienne.

Q104. Méningites infectieuses

Vous recevez aux urgences une femme de 25 ans pour un syndrome méningé fébrile. Elle n'a pas d'antécédent notable. Elle présente depuis 3 jours une pharyngite sans amygdalite, avec une fièvre à 38,6°C. L'examen physique à l'arrivée montre : T= 39°, FC= 100/min, PA= 100/60 mm Hg, FR=16 cycles/min ; Somnolence, obnubilation ; Macules violacées ne s'effaçant pas à la vitropression ; Raideur méningée. Vous réalisez une ponction lombaire. Quels sont les résultats attendus ?

- A) Liquide clair.
- B) Pléiocytose à prédominance polynucléaire neutrophiles.
- C) Protéïnorachie > 1g/L.
- D) Rapport glycorachie / glycémie < 0.5.
- E) Il est possible de rechercher le germe par PCR.

Q105. Méningites infectieuses

Vous recevez aux urgences une femme de 25 ans pour un syndrome méningé fébrile. Elle n'a pas d'antécédent notable. Elle présente depuis 3 jours une pharyngite sans amygdalite, avec une fièvre à 38,6°C. L'examen physique à l'arrivée montre : T= 39°, FC= 100/min, PA= 100/60 mm Hg, FR=16 cycles/min ; Somnolence, obnubilation ; Macules violacées ne s'effaçant pas à la vitropression ; Raideur méningée. Les résultats du LCR confirment votre suspicion. Quel (s) traitement (s) administrez-vous ?

- A) Dexaméthasone.
- B) Aciclovir.
- C) Amoxicilline-Acide clavulanique.
- D) Ceftriaxone.
- E) Gentamicine.

Q106. Méningites infectieuses

Vous recevez aux urgences une femme de 25 ans pour un syndrome méningé fébrile. Elle n'a pas d'antécédent notable. Elle présente depuis 3 jours une pharyngite sans amygdalite, avec une fièvre à 38,6°C. L'examen physique à l'arrivée montre : T= 39°, FC= 100/min, PA= 100/60 mm Hg, FR=16 cycles/min ; Somnolence, obnubilation ; Macules violacées ne s'effaçant pas à la vitropression ; Raideur méningée. Concernant la prise en charge des sujets contacts, quelle (s) est (sont) l'(les) affirmation(s) exacte(s) ?

- A) Déclaration obligatoire.
- B) Vaccination selon le sérotype.
- C) Antibio prophylaxie par rifampicine.
- D) Antibio prophylaxie par amoxicilline.
- E) Pas de traitement de prophylaxie.

Q107. Tétanos

Vous recevez un homme de 59 ans pour une plaie délabrante de l'avant-bras. Il s'est blessé 3 jours auparavant en escaladant un fil de fer. Il n'a aucun antécédent notable et n'a reçu aucune vaccination depuis l'enfance. Quelles sont les éléments à haut risque tétanigène cités dans l'observation ?

- A) Délai de la prise en charge.
- B) Mécanisme de la plaie.
- C) Aspect de la plaie.
- D) Vaccination antitétanique ancienne.
- E) Sexe masculin.

Q108. Tétanos

Vous recevez un homme de 59 ans pour une plaie délabrante de l'avant-bras. Il s'est blessé 3 jours auparavant en escaladant un fil de fer. Il n'a aucun antécédent notable et n'a reçu aucune vaccination depuis l'enfance. Quelles mesures prophylactiques proposez-vous ?

- A) Administration d'immunoglobulines tétaniques humaine.
- B) Administration immédiate de vaccin antirabique.
- C) Mettre un pansement occlusif.
- D) Antibiothérapie.
- E) Vaccination par le DTC (diphtérie, tétanos, coqueluche).

Q109. AES

En cas d'accident d'exposition au sang, quelle (s) est (sont) la (les) mesure(s) de protection vis-à-vis du risque du VHB ?

- A) Traitement antiviral post exposition.
- B) Administrations d'immunoglobulines spécifiques.
- C) Vaccination anti VHB.
- D) Traitement immunomodulateur prophylactique par interféron pégylé.
- E) Il n'existe pas de prophylaxie vis-à-vis du risque du VHB.

Q110. Infection à VIH

Parmi les signes suivants, quels sont ceux que vous retrouvez lors de la primo-infection à VIH :

- A) Ulcérations génitales.

- B) Éruption cutanée.
- C) Sarcome de Kaposi.
- D) Diarrhée chronique.
- E) Méningite lymphocytaire.

Q111. Infection à VIH

Concernant la primo-infection à VIH reprenez les propositions exactes :

- A) La charge virale est indétectable.
- B) La réplication virale est intense.
- C) Le risque de transmission virale est faible.
- D) Le taux des CD4 est bas.
- E) La sérologie VIH est négative.

Q112. Leptospirose

Parmi les éléments suivants, indiquez celui ou ceux qui vous paraissent (paraissent) évocateurs de la leptospirose ?

- A) Ictère.
- B) Insuffisance rénale.
- C) Méningite purulente.
- D) Hyperleucocytose.
- E) Thrombopénie.

Q113. Leptospirose

Parmi les examens complémentaires suivants lequel permet de poser en routine le diagnostic de la leptospirose ?

- A) L'hémoculture.
- B) Le Western blot.
- C) Le Test d'agglutination microscopique (MAT).
- D) L'antigénémie.
- E) La bandelette urinaire.

Q114. Fièvre typhoïde

Quels sont les examens de confirmation de la fièvre typhoïde ?

- A) Myéloculture.
- B) Coproculture.
- C) Hémoculture.
- D) Sérodiagnostic de Widal et Félix.
- E) Examen parasitologique des selles.

Q115. Infection à VIH

Mme F.A âgée de 32 ans séropositive au VIH consulte pour une baisse de l'acuité visuelle depuis 3 jours. Examen clinique trouve une patiente stable sur la plan hémodynamique et respiratoire présente une candidose buccale le reste de l'examen est sans particularités. Le fond d'oeil a montré une hémorragie rétinienne en faveur d'une rétinopathie à Cytomégalovirus. Quel (s) est (sont) les antiviropiques que vous pouvez prescrire chez cette patiente ?

- A) Valganciclovir.
- B) Fluconazole.
- C) Aciclovir.
- D) Valaciclovir.
- E) Voriconazole.

Q116. Méningites infectieuses

Indiquez-la ou les propositions exactes concernant l'acyclovir :

- A) Il agit par inhibition de la synthèse de l'ADN viral.
- B) Nécessite la surveillance du taux des PNN.
- C) Indiqué dans l'oesophagite à cytomegalovirus.
- D) Il agit sur les herpès simplex virus de type 1 et 2 et sur le cytomegalovirus.
- E) C'est le traitement de référence de la méningo-encéphalite herpétique.

Q117. Infections à streptocoques

Vous recevez une femme de 72 ans diabétique type 2 sous metformine et HTA sous amlodipine pour une douleur fébrile de la jambe droite évoluant depuis 24h. L'examen clinique montre une température 39.3 et TA 140/70mmHg FC 100/min, placard oedémateux rouge chaud induré douloureux bien limité de la jambe droite avec aspect érosif et macéré des 2 derniers espaces inter digitaux plantaire des 2 pieds. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Thrombose veineuse profonde.
- B) Ecthyma.
- C) Syndrome de Stevens Johnson.
- D) Fasciite nécrosante.
- E) Dermohypodermite bactérienne non nécrosante.

Q118. Infections à streptocoques

Vous recevez une femme de 72 ans diabétique type 2 sous metformine et HTA sous amlodipine pour une douleur fébrile de la jambe droite évoluant depuis 24h. L'examen clinique montre une température 39.3 et TA 140/70mmHg FC 100/min, placard oedémateux rouge chaud induré douloureux bien limité de la jambe droite avec aspect érosif et macéré des 2 derniers espaces inter digitaux plantaire des 2 pieds. Quel est le germe le plus probable ?

- A) Streptococcus pyogenes.

- B) Streptococcus Agalactiae.
- C) Staphylococcus Aureus.
- D) Staphylococcus à coagulase négative.
- E) Escherichia coli entérohémorragique.

Q119. Infections à streptocoques

Vous recevez une femme de 72 ans diabétique type 2 sous metformine et HTA sous amlodipine pour une douleur fébrile de la jambe droite évoluant depuis 24h. L'examen clinique montre une température 39.3 et TA 140/70mmHg FC 100/min, placard oedémateux rouge chaud induré douloureux bien limité de la jambe droite avec aspect érosif et macéré des 2 derniers espaces inter digitaux plantaire des 2 pieds. Quels sont les 2 antibiotiques de 1ère intention ?

- A) Amoxicilline.
- B) Amoxicilline-acide clavulanique.
- C) Pénicilline G.
- D) Pénicilline M.
- E) Pristinamycine.

Q120. Septicémies à staphylocoques

L'ostéomyélite aiguë des membres du grand enfant se manifeste habituellement à son début par :

- A) Une fièvre élevée.
- B) Une douleur intense.
- C) Une impotence fonctionnelle.
- D) Une absence d'anomalie radiologique.
- E) Un risque de fracture de l'os.

Q121. Infections à streptocoques

Parmi les signes suivants, indiquez celui ou ceux qui sont caractéristiques de la scarlatine :

- A) Enanthème.
- B) Éruption maculopapuleuse sans intervalle de peau saine.
- C) Adénopathie cervicale.
- D) Langue framboisée.
- E) Angine érythémateuse.

Q122. Rage

Le virus de la rage peut être transmis à l'homme par :

- A) Manipulation d'un chien mort.
- B) Morsure par un patient enragé.
- C) Léchage de plaie par un chien enragé.
- D) Voie aérienne par inhalation dans les grottes.
- E) Contamination du personnel de laboratoire.

Q123. Rage

La symptomatologie de la rage est expliquée par :

- A) Fixation d'une toxine sur le système nerveux.
- B) Diffusion du germe dans le sang.
- C) Abscès cérébral.
- D) Localisation du germe au niveau de l'hippocampe.
- E) Réactivation du virus qui était en état de latence.

Q124. Rage

Le risque de contamination par le virus de la rage est plus élevé en cas de :

- A) Léchage sur une peau intacte.
- B) Morsure par un animal errant.
- C) Morsure au niveau des mains.
- D) Morsure au niveau d'une peau lésée.
- E) Morsure par un chien vacciné.

Q125. Infections liées aux tiques

Un jeune de 29 ans, sans antécédents, s'est présenté aux urgences pour une fièvre d'installation brutale, arthromyalgies et céphalées évoluant depuis 3 jours sans autres signes fonctionnels associés. À l'examen physique : Un état général conservé, Température : 39°C et pas d'éruption cutanée. À ce stade quels sont les diagnostics à évoquer ?

- A) Hépatite virale A.
- B) Leptospirose.
- C) Paludisme.
- D) Fièvre boutonneuse méditerranéenne.
- E) Covid-19.

Q126. Infections liées aux tiques

Un jeune de 29 ans, sans antécédents, s'est présenté aux urgences pour une fièvre d'installation brutale, arthromyalgies et céphalées évoluant depuis 3 jours sans autres signes fonctionnels associés. À l'examen physique : Un état général conservé, Température : 39°C et pas d'éruption cutanée. Quels autres éléments de l'interrogatoire recherchez-vous pour affiner votre diagnostic ?

- A) Profession.
- B) Retour de voyage.
- C) Cas similaires dans l'entourage.

- D) Animaux.
- E) Piqûre d'insectes.

Q127. Infections liées aux tiques

C'est un fermier sans cas similaires dans la famille, pas de notion de voyage récent ne rapporte pas de piqure d'insectes. Le patient a été traité par du paracétamol et il est rentré chez lui, deux jours plus tard, le patient reconsulte aux urgences pour persistance de la fièvre, des céphalées, l'apparition de vomissement et d'une éruption cutanée généralisée. Biologie : Gb : 3500 éléments/mm³, Hb : 12g/dl, Plq : 85000élem/mm³, Fonction rénale correcte et un ionogramme normal, Cytolyse hépatique à 2 x la normale. Quel est votre diagnostic ?

- A) Fièvre typhoïde.
- B) Fièvre boutonneuse méditerranéenne.
- C) Fièvre Q.
- D) Paludisme.
- E) Hépatite virale A.

Q128. Infections liées aux tiques

C'est un fermier sans cas similaires dans la famille, pas de notion de voyage récent ne rapporte pas de piqure d'insectes. Le patient a été traité par du paracétamol et il est rentré chez lui, deux jours plus tard, le patient reconsulte aux urgences pour persistance de la fièvre, des céphalées, l'apparition de vomissement et d'une éruption cutanée généralisée. Biologie : Gb : 3500 éléments/mm³, Hb : 12g/dl, Plq : 85000élem/mm³, Fonction rénale correcte et un ionogramme normal, Cytolyse hépatique à 2 x la normale. Quel est le germe en cause ?

- A) *Coxiella burnetii*.
- B) *Plasmodium falciparum*.
- C) *Rickettsia conorii*.
- D) *Salmonella typhi*.
- E) Virus de l'hépatite A (VHA).

Q129. Infections liées aux tiques

Pour confirmer ce diagnostic vous allez compléter par :

- A) Hémocultures.
- B) Sérologie IFI.
- C) Western Blot.
- D) Goutte épaisse et frottis mince.
- E) PCR sur la biopsie cutanée.

Q130. Infections liées aux tiques

Quel traitement prescrivez-vous ?

- A) Doxycycline 200mg/jour.
- B) Métronidazole 500mg fois 3/jour.
- C) Amoxicilline 3g/jour.
- D) Nirmatrelvir/ritonavir.
- E) Artéméter-luméfantrine.

Q131. Toxoplasmose

Une femme de 30 ans, enceinte de 12 semaines, se présente pour une consultation prénatale. Elle a un bon état de santé général, mais mentionne qu'elle consomme régulièrement des légumes crus qu'elle prépare elle-même et qu'elle a un chat depuis plusieurs années. Elle n'a pas d'antécédents médicaux notables. Quel test est le plus adapté pour évaluer si cette patiente a déjà été exposée à *Toxoplasma gondii* ?

- A) Dosage des anticorps IgG et IgM spécifiques de *Toxoplasma gondii*.
- B) Sérologie pour la recherche d'IgA spécifiques de *Toxoplasma gondii*.
- C) Test d'amplification d'acides nucléiques (PCR) sur échantillon sanguin.
- D) Culture du parasite à partir d'un échantillon de sang.

Q132. Toxoplasmose

Une femme de 30 ans, enceinte de 12 semaines, se présente pour une consultation prénatale. Elle a un bon état de santé général, mais mentionne qu'elle consomme régulièrement des légumes crus qu'elle prépare elle-même et qu'elle a un chat depuis plusieurs années. Elle n'a pas d'antécédents médicaux notables. Quel facteur de risque signalé par la patiente est le plus étroitement lié à la transmission de *Toxoplasma gondii* ?

- A) La présence d'un chat domestique.
- B) La consommation de légumes crus mal lavés.
- C) La préparation de repas à base de viande cuite à point.
- D) Le contact occasionnel avec le sol en jardinant.

Q133. Toxoplasmose

Une femme de 30 ans, enceinte de 12 semaines, se présente pour une consultation prénatale. Elle a un bon état de santé général, mais mentionne qu'elle consomme régulièrement des légumes crus qu'elle prépare elle-même et qu'elle a un chat depuis plusieurs années. Elle n'a pas d'antécédents médicaux notables. Quelles recommandations de prévention pourriez-vous proposer à cette patiente pour réduire son risque d'infection pendant la grossesse ?

- A) Éviter tout contact direct avec son chat.
- B) Cuire la viande à une température d'au moins 65°C.
- C) Laver soigneusement les légumes crus et les fruits avant consommation.
- D) Porter un masque en extérieur pour éviter l'exposition aux oocystes.

Q134. Toxoplasmose

Une infection primaire par *Toxoplasma gondii* peut entraîner :

- A) Une malformation congénitale sévère avec microcéphalie.
- B) Une infection asymptomatique chez le fœtus à la naissance.
- C) Une hydrocéphalie ou une chorioretinite congénitale.
- D) Une mort fœtale précoce sans autres anomalies détectables.

Q135. Amébose et amibes intestinales

Un homme de 35 ans, consulte pour une diarrhée glairo-sanglante apparue il y a cinq jours, associée à des douleurs abdominales diffuses, une fièvre modérée (38°C) et une fatigue importante. Il rapporte qu'il consomme régulièrement des crudités et de l'eau de source non traitée. L'examen clinique révèle une sensibilité marquée à la palpation de l'hypogastre et de la fosse iliaque droite. Une parasitose intestinale est suspectée. L'agent pathogène le plus probablement responsable est ?

- A) *Giardia lamblia*.
- B) *Entamoeba histolytica*.
- C) *Balantidium coli*.
- D) *Cryptosporidium parvum*.

Q136. Amébose et amibes intestinales

Un homme de 35 ans, consulte pour une diarrhée glairo-sanglante apparue il y a cinq jours, associée à des douleurs abdominales diffuses, une fièvre modérée (38°C) et une fatigue importante. Il rapporte qu'il consomme régulièrement des crudités et de l'eau de source non traitée. L'examen clinique révèle une sensibilité marquée à la palpation de l'hypogastre et de la fosse iliaque droite. Une parasitose intestinale est suspectée. Quel est l'examen à demander en première intention pour confirmer le diagnostic ?

- A) Examen parasitologique des selles.
- B) Sérologie pour la recherche d'anticorps spécifiques.
- C) Biopsie hépatique.
- D) Dosage des graisses fécales.

Q137. Amébose et amibes intestinales

Un homme de 35 ans, consulte pour une diarrhée glairo-sanglante apparue il y a cinq jours, associée à des douleurs abdominales diffuses, une fièvre modérée (38°C) et une fatigue importante. Il rapporte qu'il consomme régulièrement des crudités et de l'eau de source non traitée. L'examen clinique révèle une sensibilité marquée à la palpation de l'hypogastre et de la fosse iliaque droite. Une parasitose intestinale est suspectée. Quel est le mode de contamination principal de cette parasitose ?

- A) Transmission par voie aérienne.
- B) Consommation de poissons crus pêchés localement.
- C) Ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par des kystes du parasite.
- D) Piqûre d'insecte vecteur.

Q138. Amébose et amibes intestinales

Un homme de 35 ans, consulte pour une diarrhée glairo-sanglante apparue il y a cinq jours, associée à des douleurs abdominales diffuses, une fièvre modérée (38°C) et une fatigue importante. Il rapporte qu'il consomme régulièrement des crudités et de l'eau de source non traitée. L'examen clinique révèle une sensibilité marquée à la palpation de l'hypogastre et de la fosse iliaque droite. Une parasitose intestinale est suspectée. Quelles complications peuvent survenir si cette parasitose n'est pas traitée ?

- A) Perforation intestinale.
- B) Syndrome de malabsorption sévère.
- C) Insuffisance rénale aiguë secondaire à une déshydratation.
- D) Abcès hépatique.

Q139. Nématelminthes

Un enfant de 7 ans présente des démangeaisons anales nocturnes, des troubles du sommeil, et se gratte fréquemment. D'autres enfants de son entourage ont des symptômes similaires. Quelle est la parasitose la plus probable ?

- A) Ascarirose.
- B) Oxyurose.
- C) Toxocarose.
- D) Giardiase.

Q140. Nématelminthes

L'agent responsable de l'oxyurose est :

- A) *Ascaris lumbricoides*.
- B) *Enterobius vermicularis*.
- C) *Taenia saginata*.
- D) *Trichuris trichiura*.

Q141. Nématelminthes

Le mode de contamination de l'oxyurose se fait principalement par :

- A) Piqûre de moustique.
- B) Ingestion d'eau contaminée.
- C) Ingestion d'œufs par contact main-bouche après contamination de l'environnement.
- D) Inhalation des œufs.

Q142. Nématelminthes

L'examen à demander en première intention pour confirmer le diagnostic d'oxyurose est :

- A) Examen parasitologique des selles.
- B) Frottis sanguin.

- C) Le test scotch anal.
- D) Échographie abdominale.

Q143. Plathelminthes

Un homme de 40 ans consulte pour des douleurs abdominales diffuses et intermittentes, accompagnées d'une sensation de ballonnement et d'une perte de poids progressive, malgré un appétit conservé. Il rapporte également un inconfort au niveau de la région anale, surtout nocturne, ainsi que la présence occasionnelle de segments blancs mobiles dans ses selles. Quel(s) est le parasite(s) le plus probablement responsable (s) de cette parasitose ?

- A) Taenia solium.
- B) Taenia saginata.
- C) Ascaris lumbricoides.
- D) Enterobius vermicularis.

Q144. Plathelminthes

À l'interrogatoire le patient rapporte avoir consommé régulièrement de la viande de boeuf peu cuite. Quel est le parasite le plus probablement responsable de cette parasitose ?

- A) Taenia solium.
- B) Taenia saginata.
- C) Ascaris lumbricoides.
- D) Enterobius vermicularis.

Q145. Plathelminthes

Quel élément clinique et anamnestique est en faveur de Taenia saginata ?

- A) Perte du poids inexplicable malgré un bon appétit.
- B) Prurit anal.
- C) Consommation de viande de boeuf peu cuite.
- D) Présence segments blancs mobiles dans les selles.

Q146. Plathelminthes

Quel examen permet de confirmer le diagnostic de taeniasis à T. saginata ?

- A) Examen microscopique des selles avec coloration de Gram.
- B) Identification macroscopique des segments mobiles.
- C) Test sérologique pour anticorps antiparasitaires.
- D) Biopsie intestinale avec examen histologique.

Q147. Leishmaniose

Quelle stratégie de prévention recommandée pour réduire le risque de transmission de la leishmaniose au Maroc ?

- A) La vaccination systématique de la population.
- B) L'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide.
- C) La prise prophylactique d'antipaludiques.
- D) La réduction des populations de phlébotomes et le contrôle des réservoirs animaux.

Q148. Dermatophytes et dermatophytoses

Trichophyton rubrum est :

- A) Une levure opportuniste.
- B) Un dermatophyte.
- C) Un bacille Gram-négatif.
- D) Un virus cutané.

Q149. Nématodoses digestives

Quelle est la complication la plus grave liée à une infection chronique par Strongyloides stercoralis chez une personne immunodéprimée ?

- A) Dermatite étendue causée par le passage des larves.
- B) Surinfection bactérienne due à l'invasion intestinale.
- C) Syndrome d'hyperinfection avec dissémination systémique.
- D) Diarrhée chronique non compliquée.

Q150. Paludisme MI

Quel est le mode de transmission du paludisme ?

- A) Piqûre d'un moustique du genre Aedes.
- B) Piqûre d'un moustique du genre Anopheles.
- C) Ingestion d'eau contaminée.
- D) Contact direct avec une personne infectée.

SEPTEMBRE 2024

Q151. Flagelloses intestinales et uro-génitales

Quelle est la méthode de transmission la plus fréquente de Giardia intestinalis ?

- A) Transmission par gouttelettes.
- B) Transmission oro-fécale.
- C) Contact cutané direct.
- D) Transfusion sanguine.

Q152. Paludisme MI

Le parasite responsable du paludisme est :

- A) Trypanosoma brucei.
- B) Plasmodium falciparum.
- C) Leishmania donovani.
- D) Entamoeba histolytica.

Q153. Leishmaniose

Le vecteur de la leishmaniose est :

- A) Phlébotome (mouche des sables).
- B) Moustique.
- C) Tique.
- D) Puce.

Q154. Amébose et amibes intestinales

Quel stade de l'Entamoeba histolytica est infectieux pour l'hôte humain ?

- A) Trophozoïte.
- B) Sporozoïte.
- C) Kyste.
- D) Gamétocyte.

Q155. Nématodoses digestives

Dans un contexte clinique, quel est le stade diagnostique de l'Ascaris lumbricoides dans les selles ?

- A) Larve.
- B) Ver adulte.
- C) Œuf fécondé.
- D) Kyste.

Q156. Plathelminthes

Taenia solium est également connue sous le nom de :

- A) Ankylostome.
- B) Oxyure.
- C) Ténia du porc.
- D) Ténia du bœuf.

Q157. Infection à VIH

Une manifestation typique de l'infection par Toxoplasma gondii chez les patients immunodéprimés est :

- A) Chorioretinite.
- B) Malabsorption.
- C) Hépatosplénomégalie.
- D) Ulcères cutanés.

Q158. Introduction à la parasitologie médicale

Lequel des parasites suivants n'est pas un protozoaire ?

- A) Giardia lamblia.
- B) Entamoeba histolytica.
- C) Ancylostoma duodenale.
- D) Trypanosoma cruzi.

Q159. Nématodoses digestives

Le symptôme clinique le plus fréquent de l'infection par Enterobius vermicularis est :

- A) Prurit anal nocturne.
- B) Hémoptysie.
- C) Ictère.
- D) Dysenterie.

Q160. Paludisme MI

La caractéristique diagnostique de l'infection par Plasmodium dans un frottis sanguin est :

- A) Trophozoïtes.
- B) Gamétocytes en forme de croissant.
- C) Schizontes.
- D) Microfilaires dans le sang.

Q161. Hydatidose

Quel parasite est diagnostiqué par la présence de sable hydatique dans le liquide d'un kyste ?

- A) Echinococcus granulosus.
- B) Schistosoma japonicum.
- C) Fasciola hepatica.
- D) Paragonimus westermani.

Q162. Némathelminthes

Quel parasite est responsable du syndrome de larva migrans cutané ?

- A) Ascaris lumbricoides.
- B) Enterobius vermicularis.

- C) *Strongyloides stercoralis*.
- D) *Trichinella spiralis*.

Q163. Introduction à la parasitologie médicale

Quel parasite est transmis par la piqûre de la mouche tsé-tsé ?

- A) *Trypanosoma brucei*.
- B) *Leishmania donovani*.
- C) *Plasmodium vivax*.
- D) *Toxoplasma gondii*.

Q164. Coccidioses intestinales

Le diagnostic de l'infection par *Cryptosporidium* est principalement basé sur :

- A) Culture sanguine.
- B) Examen des selles pour les oocystes.
- C) Sérologie.
- D) Biopsie cutanée.

Q165. Nématelminthes

Strongyloides stercoralis est unique parmi les helminthes pour sa capacité à :

- A) Provoquer une auto-infection.
- B) Être transmis par un vecteur.
- C) Être transmis par l'eau.
- D) Être transmis par voie aérienne.

Q166. Leishmaniose

En Inde, l'hôte réservoir principal de *Leishmania donovani* est :

- A) L'humain.
- B) Les rongeurs.
- C) Les chiens.
- D) Le bétail.

Q167. Plathelminthes

Quelle infection parasitaire est le plus souvent associée à la consommation de porc contaminé ?

- A) *Taenia solium*.
- B) *Trichinella spiralis*.
- C) *Ascaris lumbricoides*.
- D) *Enterobius vermicularis*.

Q168. Flagelloses intestinales et uro-génitales

Le symptôme clinique le plus courant de l'infection par *Giardia intestinalis* est :

- A) Diarrhée chronique.
- B) Hématurie.
- C) Sueurs nocturnes.
- D) Lymphadénopathie.

Q169. Toxoplasmose

Quelle forme de *Toxoplasma gondii* est responsable des infections congénitales ?

- A) Tachyzoïte.
- B) Bradyzoïte.
- C) Oocyste.
- D) Sporozoïte.

Q170. Leishmaniose

La méthode la plus sensible pour diagnostiquer une infection par *Leishmania cutanée* est :

- A) Frottis sanguin.
- B) Aspiration de moelle osseuse.
- C) Biopsie de ganglion lymphatique.
- D) Tests sérologiques.

Q171. Toxoplasmose

Quel parasite peut être transmis verticalement de la mère à l'enfant ?

- A) *Enterobius vermicularis*.
- B) *Toxoplasma gondii*.
- C) *Ascaris lumbricoides*.
- D) *Giardia intestinalis*.

Q172. Introduction à la parasitologie médicale

Quelle est la caractéristique morphologique typique des nématodes ?

- A) Ils sont aplatis dorso-ventralement.
- B) Ils ont un corps segmenté.
- C) Ils ont un corps cylindrique et non segmenté.
- D) Ils ont une coquille dure autour de leur corps.

Q173. Nématodoses digestives

Quel est le cycle de vie d'Entérovirus vermicularis ?

- A) Direct avec un seul hôte.
- B) Indirect avec deux hôtes intermédiaires.
- C) Cycle libre sans hôte.
- D) Cycle aquatique avec développement larvaire dans l'eau.

Q174. Nématelminthes

Quelle est la méthode de diagnostic couramment utilisée pour détecter une infection par Strongyloides stercoralis ?

- A) Test sérologique.
- B) Examen des selles à la recherche de larves.
- C) Biopsie intestinale.
- D) Culture de sang.

Q175. Paludisme MI

Concernant le paludisme, quelles sont les propositions exactes ?

- A) Le paludisme est une protozoose.
- B) On connaît actuellement 5 espèces plasmodiales.
- C) Le réservoir de l'hématozoaire du genre plasmodium est humain.
- D) Le vecteur du parasite est l'anophèle femelle.
- E) La majorité des cas mondiaux est due à plasmodium malariae.

Q176. Paludisme MI

Les signes biologiques classiques au cours d'un accès palustre sont :

- A) Thrombopénie.
- B) Anémie hémolytique.
- C) Hyperleucocytose.
- D) Hyperéosinophilie.
- E) Cytolyse hépatique.

Q177. Infections liées aux tiques

Quelles sont les caractéristiques de l'érythème migrans ?

- A) Il s'agit d'une macule érythémateuse, centrée par le point de piqure.
- B) L'évolution est centrifuge.
- C) Le centre s'éclaircit progressivement.
- D) L'érythème migrans disparaît spontanément en 3 à 4 semaines.
- E) L'éruption est prurigineuse.

Q178. Rage

Comment évalue-t-on le risque de rage après une morsure d'animal ?

- A) Mise de l'animal sous contrôle vétérinaire.
- B) Absence de risque si l'animal est toujours vivant à J7.
- C) Absence de risque si l'animal est toujours vivant à J15.
- D) Euthanasie de l'animal et mise en culture des neurones.
- E) Apparition des symptômes chez l'animal mordeur.

Q179. Tétanos

Vous recevez un homme de 59 ans pour une plaie délabrante de l'avant-bras. Il s'est blessé 3 jours auparavant en escaladant un fil de fer. Il n'a aucun antécédent notable et n'a reçu aucune vaccination depuis l'enfance. Quelles sont les éléments à haut risque tétanigène cités dans l'observation ?

- A) Délai de prise en charge.
- B) Mécanisme de la plaie.
- C) Aspect de la plaie.
- D) Vaccination antitétanigène ancienne.
- E) Sexe masculin.

Q180. Tétanos

Quelles mesures prophylactiques proposez-vous chez ce patient (blessure de 3 jours, non vacciné) ?

- A) Administration d'immunoglobulines tétanique humaine.
- B) Administration immédiate de vaccin antitétanique.
- C) Mettre un pansement occlusif.
- D) Antibiothérapie.
- E) Vaccination par le DTC (diphtérie, tétanos, coqueluche).

Q181. Septicémies à staphylocoques

En cas d'endocardite infectieuse à staphylocoque méthi-sensible, quel schéma thérapeutique vous proposez en première intention ?

- A) Céphalosporine de 3ème génération + Gentamycine pendant 2 semaines.
- B) Céphalosporine de 3ème génération + Gentamycine pendant 6 semaines.
- C) Vancomycine + Gentamycine pendant 2 semaines.
- D) Céphalosporine de 3ème génération pendant 2 semaines.
- E) Céphalosporine de 3ème génération pendant 6 semaines.

Q182. Méningites infectieuses

Vous recevez aux urgences une femme de 25 ans pour un syndrome méningé fébrile. Elle présente depuis 3 jours une pharyngite

érythémateuse. L'examen montre une fièvre à 39°C, une somnolence et des macules violacées ne s'effaçant pas à la vitropression. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Méningite à Méningocoque.
- B) Méningite à Pneumocoque.
- C) Méningite Virale.
- D) Méningite Tuberculeuse.
- E) Méningite Listérienne.

Q183. Méningites infectieuses

Vous réalisez une ponction lombaire chez cette patiente. Quels sont les résultats attendus ?

- A) Liquide clair.
- B) Pléiocytose à prédominance polynucléaire neutrophiles.
- C) Protéïnorachie < 1g/L.
- D) Rapport glycorachie / glycémie < 0.5.
- E) Il est possible de rechercher le germe par PCR.

Q184. Méningites infectieuses

Les résultats du LCR confirment votre suspicion (Méningocoque). Quel (s) traitement (s) administrez-vous ?

- A) Dexaméthasone.
- B) Aciclovir.
- C) Amoxicilline-Acide clavulanique.
- D) Ceftriaxone.
- E) Gentamicine.

Q185. Méningites infectieuses

Concernant la prise en charge des sujets contacts du cas de méningite à méningocoque, quelle (s) est (sont) l' (les) affirmation (s) exacte (s) ?

- A) Déclaration obligatoire.
- B) Vaccination selon le sérotype.
- C) Antibio prophylaxie par rifampicine.
- D) Antibio prophylaxie par amoxicilline.
- E) Pas de traitement de prophylaxie.

Q186. AES

Concernant les accidents d'exposition au sang, quelles sont les situations associées à un risque important de transmission du VIH ?

- A) Piqûre avec une aiguille creuse.
- B) Piqûre avec un dispositif intravasculaire.
- C) Piqûre avec une aiguille IM.
- D) Piqûre avec une aiguille SC.
- E) Piqûre avec une seringue abandonnée.

Q187. AES

Dans quels délais le traitement antirétroviral post exposition peut-il être mis en route ?

- A) Moins de 4h après l'exposition à risque.
- B) 4 à 12h après l'exposition à risque.
- C) 24 à 48h après l'exposition à risque.
- D) 12 à 72h après l'exposition à risque.
- E) 12 à 96h après l'exposition à risque.

Q188. AES

En cas d'accident d'exposition au sang, quelle (s) est (sont) la (les) mesures de protection vis-à-vis du risque VHC ?

- A) Vaccination anti VHC.
- B) Administrations d'immunoglobulines spécifiques.
- C) Traitement immunomodulateur prophylactique par interféron pégylé.
- D) Traitement antiviral post exposition.
- E) Il n'existe pas de prophylaxie vis-à-vis du risque VHC.

Q189. TIAC

Vous recevez en urgence Mr A.H âgé de 58 ans pour des diarrhées liquidiennes d'installation brutale sans sang ni glaires. Sa femme a aussi la diarrhée. Vous reprenez le diagnostic de toxi-infection alimentaire collective (TIAC), Quel (s) est (sont) l' (les) affirmation (s) en faveur de ce diagnostic ?

- A) Des cas similaires dans l'entourage.
- B) Les symptômes cliniques sont toujours digestifs.
- C) Il faut identifier un repas commun.
- D) La symptomatologie peut apparaître après 1h d'ingestion de la toxine.
- E) La fièvre est toujours présente.

Q190. TIAC

Quel est le germe le plus incriminé dans cette TIAC (diarrhée liquidienne, brutale, pas de sang) ?

- A) Staphylococcus aureus.
- B) Yersinia enterocolitica.
- C) Clostridium botulinum.
- D) Shigella.

E) Salmonella non typhique.

Q191. Leptospirose

Ahmed, vétérinaire, passionné d'activités aquatiques, présente depuis 48h une fièvre à 39°C, céphalées, myalgies et arthralgies. L'examen trouve un ictère cutanéomuqueux et une oligurie. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Grippe saisonnière.
- B) Méningite virale.
- C) Primo infection à VIH.
- D) Leptospirose.
- E) Hépatite virale A.

Q192. Leptospirose

Quel (s) est (sont) le (s) modes de transmission de cette infection (Leptospirose) ?

- A) Inhalation de gouttelettes salivaires.
- B) Rapports sexuels non protégés.
- C) Pénétration par voie transcutanée à travers une peau fine saine.
- D) Pénétration par voie muqueuse.
- E) Ingestion d'aliments contaminés.

Q193. Leptospirose

Par quel (s) moyen (s) pouvez-vous en faire le diagnostic chez ce patient ?

- A) Test d'agglutination microscopique (MAT).
- B) Sérologie VIH.
- C) PCR Herpès Simplex Virus dans le LCR.
- D) Sérologie de l'hépatite virale A.
- E) PCR leptospirose dans le sang.

Q194. Leptospirose

Quelle (s) antibiothérapie (s) curative (s) pouvez-vous prescrire chez ce patient ?

- A) Ofloxacin per os 7 jours.
- B) Amoxicilline IV 7 jours.
- C) Doxycycline per os 7 jours.
- D) Ceftriaxone IV 7 jours.
- E) Aciclovir IV 14 jours.

Q195. Infection à CMV

Mme F.A âgée de 32 ans séropositive au VIH consulte pour une baisse de l'acuité visuelle. Le fond d'oeil a montré une hémorragie rétinienne en faveur d'une rétinite à Cytomégalovirus. Quel (s) est (sont) les antiviraux que vous pouvez prescrire ?

- A) Valganciclovir.
- B) Fluconazole.
- C) Aciclovir.
- D) Valaciclovir.
- E) Voriconazole.

Q196. Infections à streptocoques

Femme de 72 ans, diabétique et HTA, présente une température à 39.3, un placard oedémateux rouge chaud induré douloureux bien limité de la jambe droite avec aspect érosif interdigital. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Thrombose veineuse profonde.
- B) Dermohypodermite bactérienne non nécrosante.
- C) Ecthyma.
- D) Syndrome de Stevens Johnson.
- E) Fasciite nécrosante.

Q197. Infections à streptocoques

Quel est le germe le plus probable (Erysipèle) ?

- A) Streptococcus pyogenes.
- B) Streptococcus Agalactiae.
- C) Staphylococcus Aureus.
- D) Staphylococcus à coagulase négative.
- E) Escherichia coli entérohémorragique EHEC.

Q198. Infections à streptocoques

Quels sont les 2 antibiotiques de 1ère intention ?

- A) Amoxicilline.
- B) Amoxicilline-acide clavulanique.
- C) Pénicilline G.
- D) Pénicilline M.
- E) Pristinamycine.

NORMALE 2024

Q199. Toxoplasmose

Cas clinique 1 : Une femme enceinte de 28 ans se rend à votre clinique pour une consultation prénatale. Elle est en bonne santé et c'est sa première grossesse. Elle mentionne qu'elle a récemment adopté un chat et qu'elle aime jardiner. Vous décidez de tester sa susceptibilité à la toxoplasmose. Le test le plus couramment utilisé pour évaluer l'immunité d'une femme enceinte contre la toxoplasmose est :

- A) Test PCR sur échantillon sanguin.
- B) Dosage des anticorps IgG et IgM spécifiques de *Toxoplasma gondii*.
- C) Culture de parasites à partir d'un échantillon de sang.
- D) Échographie de dépistage foetal.

Q200. Toxoplasmose

Parmi les modes de transmission suivants, lequel n'est pas une source d'infection par *Toxoplasma gondii* chez l'homme ?

- A) Ingestion de viande crue ou mal cuite contaminée.
- B) Contact direct avec un chat infecté.
- C) Ingestion d'aliments souillés par des oocystes dans le sol.
- D) Transmission verticale de la mère au fœtus.

Q201. Toxoplasmose

Quelle est la conséquence la plus grave d'une infection maternelle par *Toxoplasma gondii* au cours du premier trimestre de grossesse ?

- A) Fausse couche spontanée ou mort fœtale in utero.
- B) Retard de croissance intra-utérin.
- C) Infection asymptomatique à la naissance, avec développement normal.
- D) Risque accru de prééclampsie.

Q202. Amébose et amibes intestinales

Cas clinique 2 : Un homme de 35 ans, présente depuis cinq jours une diarrhée sanglante, des douleurs abdominales diffuses, une fièvre modérée (38°C) et une fatigue. L'examen révèle une sensibilité à l'hypogastre et à la fosse iliaque droite. Il rapporte une consommation fréquente de crudités non lavées lors de ses voyages. Une Amébose intestinale est suspectée. L'agent pathogène le plus probablement responsable est :

- A) *Giardia lamblia*.
- B) *Entamoeba histolytica*.
- C) *Balantidium coli*.
- D) *Cryptosporidium parvum*.

Q203. Amébose et amibes intestinales

Quel examen permet de confirmer le diagnostic ?

- A) Sérologie sanguine.
- B) Recherche d'antigènes parasitaires dans le sang.
- C) Examen parasitologique des selles.
- D) Biopsie intestinale.

Q204. Amébose et amibes intestinales

Quel est le mode de contamination principal de cette parasitose ?

- A) Transmission par voie aérienne.
- B) Contact direct avec une personne infectée.
- C) Ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par des kystes du parasite.
- D) Piqûre d'insecte vecteur.

Q205. Nématodoses digestives

Cas clinique 3 : Un enfant de 7 ans présente des démangeaisons anales nocturnes, des troubles du sommeil, et se gratte fréquemment. D'autres enfants de son entourage ont des symptômes similaires. Quelle est la parasitose la plus probable ?

- A) Ascarirose.
- B) Oxyurose.
- C) Toxocarose.
- D) Giardiase.

Q206. Nématodoses digestives

L'agent responsable est :

- A) *Ascaris lumbricoides*.
- B) *Enterobius vermicularis*.
- C) *Taenia saginata*.
- D) *Trichuris trichiura*.

Q207. Nématodoses digestives

Le mode de contamination se fait principalement par :

- A) Piqûre de moustique.
- B) Ingestion d'eau contaminée.
- C) Ingestion d'œufs par contact main-bouche après contamination de l'environnement.
- D) Transmission par aérosols.

Q208. Nématodoses digestives

Quel examen permet de confirmer le diagnostic ?

- A) Examen parasitologique des selles.

- B) Frottis sanguin.
- C) Le test scotch anal.
- D) Échographie abdominale.

Q209. Plathelminthes

Cas clinique 4 : Un homme de 40 ans consulte pour des douleurs abdominales légères et intermittentes, associées à une perte de poids inexpliquée malgré un bon appétit. Il se plaint également d'un prurit anal. Un téniasis a été suspecté. Quel(s) est le parasite(s) le plus probablement responsable (s) de cette parasitose ?

- A) Taenia solium.
- B) Taenia saginata.
- C) Ascaris lumbricoides.
- D) Enterobius vermicularis.

Q210. Plathelminthes

A l'interrogatoire le patient rapporte avoir consommé régulièrement de la viande de boeuf peu cuite. Lors de l'examen, il est en bon état général. Une analyse de selles montre la présence de proglottis. Quel est le parasite le plus probablement responsable de cette parasitose ?

- A) Taenia solium.
- B) Taenia saginata.
- C) Ascaris lumbricoides.
- D) Enterobius vermicularis.

Q211. Plathelminthes

Quel élément clinique et anamnestique est en faveur de ce parasite ?

- A) Perte du poids inexpliquée malgré un bon appétit.
- B) Prurit anal.
- C) Consommation de viande de boeuf peu cuite.
- D) Présence de proglottis dans les selles.

Q212. Plathelminthes

Quel examen permet de confirmer le diagnostic ?

- A) Examen microscopique des selles avec coloration de Gram.
- B) Examen direct des proglottis au microscope pour identifier les orifices génitaux latéraux.
- C) Test sérologique pour anticorps antiparasitaires.
- D) Biopsie intestinale avec examen histologique.

Q213. Introduction à la mycologie

Cas clinique 5 : Mme S., 45 ans, diabétique de type 2, consulte pour une altération progressive des ongles des pieds. Elle décrit un épaississement et une décoloration jaunâtre de plusieurs ongles, associés à une légère douleur à la marche. L'examen montre des ongles épais, friables, et partiellement décollés. Une onychomycose est suspectée. Quel examen à demander pour confirmer le diagnostic ?

- A) Radiographie du pied.
- B) Examen direct au microscope et culture mycologique.
- C) Dosage des anticorps antifongiques.
- D) Biopsie de l'ongle avec examen anatomopathologique.

Q214. Dermatophytes et dermatophytoses

L'examen réalisé a permis d'identifier Trichophyton rubrum comme l'agent pathogène responsable. Trichophyton rubrum est :

- A) Une levure opportuniste.
- B) Un dermatophyte.
- C) Un bacille Gram-négatif.
- D) Un virus cutané.

Q215. Dermatophytes et dermatophytoses

Quel est le mode de contamination le plus fréquent de Trichophyton rubrum ?

- A) Transmission par l'air.
- B) Contamination par des chaussures ou des surfaces contaminées.
- C) Ingestion d'aliments contaminés.
- D) Contact avec des fluides biologiques.

Q216. Dermatophytes et dermatophytoses

Quelle mesure de prévention est recommandée pour éviter cette infection ?

- A) Utiliser des antibiotiques prophylactiques.
- B) Éviter de marcher pieds nus dans les lieux publics comme les piscines.
- C) Laver les pieds uniquement à l'eau tiède.
- D) Porter des gants lors de la manipulation des ongles.

Q217. Nématelminthes

Quelle est la complication la plus grave liée à une infection chronique par Strongyloides stercoralis chez une personne immunodéprimée ?

- A) Dermatite étendue causée par le passage des larves.
- B) Surinfection bactérienne due à l'invasion intestinale.
- C) Syndrome d'hyperinfection avec dissémination systémique.

D) Diarrhée chronique non compliquée.

Q218. Némathelminthes

Pourquoi l'anguillulose représente-t-elle un danger majeur chez les personnes immunodéprimées ?

- A) L'immunodépression empêche la production de larves infectieuses.
- B) Le parasite peut se multiplier de manière endogène, entraînant un syndrome d'hyperinfection.
- C) Les personnes immunodéprimées présentent une meilleure tolérance aux parasites.
- D) L'immunodépression réduit la capacité du parasite à migrer vers les poumons.

Q219. Némathelminthes

Quelle est la particularité du cycle de vie de *Strongyloides stercoralis* par rapport à d'autres helminthes ?

- A) Il nécessite obligatoirement deux hôtes pour compléter son cycle de vie.
- B) Il peut réaliser un cycle de vie libre en dehors de l'hôte humain.
- C) Il ne passe jamais par une phase larvaire infectieuse.
- D) Il meurt rapidement en l'absence d'un hôte humain.

Q220. Coccidioses intestinales

Quel est l'agent causal de la cryptosporidiose ?

- A) *Cryptosporidium parvum*.
- B) *Giardia lamblia*.
- C) *Entamoeba histolytica*.
- D) *Toxoplasma gondii*.

Q221. Coccidioses intestinales

Quel est le principal mode de transmission de *Cryptosporidium* ?

- A) Transfusion sanguine.
- B) Contact direct peau à peau.
- C) Ingestion d'eau ou d'aliments contaminés.
- D) Inhalation de spores aéroportées.

Q222. Coccidioses intestinales

Quelle est la meilleure approche de traitement pour la cryptosporidiose chez une personne immunocompétente ?

- A) Antibiothérapie agressive.
- B) Traitement antirétroviral pour les personnes séropositives au VIH.
- C) Réhydratation et gestion symptomatique.
- D) Vaccination préventive.

Q223. Leishmaniose

Quelle stratégie de prévention recommandée pour réduire le risque de transmission de la leishmaniose au Maroc ?

- A) La vaccination systématique de la population.
- B) L'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide.
- C) La prise prophylactique d'antipaludiques.
- D) La réduction des populations de phlébotomes et le contrôle des réservoirs animaux.

Q224. Méningites infectieuses

Cas clinique : Vous recevez aux urgences une femme de 25 ans pour un syndrome méningé fébrile. Elle n'a pas d'antécédent notable. Elle présente depuis 3 jours une pharyngite érythémateuse sans amygdalite, avec une fièvre à 38,6°C. L'examen physique à l'arrivée montre : T=39°, FC=100/min, PA=100/60 mm Hg, FR=16 cycles/min ; Somnolence, obnubilation ; Macules violacées ne s'effaçant pas à la vitro pression ; Raideur méningée. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Méningite à *Meningococcus*.
- B) Méningite à *Pneumococcus*.
- C) Méningite Virale.
- D) Méningite Tuberculeuse.
- E) Méningite Listérienne.

Q225. Méningites infectieuses

Vous réalisez une ponction lombaire. Quels sont les résultats attendus ?

- A) Liquide clair.
- B) Pléiocytose à prédominance polynucléaire neutrophiles.
- C) Protéiorachie < 1g/L.
- D) Rapport glycorachie / glycémie < 0.5.
- E) Il est possible de rechercher le germe par PCR.

Q226. Méningites infectieuses

Les résultats du LCR confirment votre suspicion. Quel (s) traitement (s) administrez-vous ?

- A) Dexaméthasone.
- B) Aciclovir.
- C) Amoxicilline-Acide clavulanique.
- D) Ceftriaxone.
- E) Gentamicine.

Q227. Méningites infectieuses

Concernant la prise en charge des sujets contacts, quelle (s) est (sont) l'(les) affirmation(s) exacte (s) ?

- A) Déclaration obligatoire.

- B) Vaccination selon le sérotype.
- C) Antibiothérapie par rifampicine.
- D) Antibiothérapie par amoxicilline.
- E) Pas de traitement de prophylaxie.

Q228. AES

Concernant les accidents d'exposition au sang, quelles sont les situations associées à un risque important de transmission du VIH ?

- A) Piqûre avec une aiguille creuse.
- B) Piqûre avec un dispositif intravasculaire.
- C) Piqûre avec une aiguille IM.
- D) Piqûre avec une aiguille SC.
- E) Piqûre avec une seringue abandonnée.

Q229. AES

Dans quels délais le traitement antirétroviral post exposition peut-il être mis en route ?

- A) Moins de 4h après l'exposition à risque.
- B) 4 à 12h après l'exposition à risque.
- C) 24 à 48h après l'exposition à risque.
- D) 12 à 72h après l'exposition à risque.
- E) 12 à 96h après l'exposition à risque.

Q230. AES

En cas d'accident d'exposition au sang, quelle (s) est (sont) la (les) mesures de protection vis-à-vis du risque VHC ?

- A) Vaccination anti VHC.
- B) Administrations d'immunoglobulines spécifiques.
- C) Traitement immunomodulateur prophylactique par interféron pégylé.
- D) Traitement antiviral post exposition.
- E) Il n'existe pas de prophylaxie vis-à-vis du risque VHC.

Q231. TIAC

Cas Clinique : Vous recevez en urgences Mr A.H âgé de 58 ans HTA sous Ramipril et diabétique type 2 sous régime seul qui consulte pour des diarrhées liquidiennes d'installation brutale sans sang ni glaires. A l'examen : TA 125/90mmHg, FC 90/min, FR 15/min, T° 37.5°C, abdomen souple sans défense et sensible de façon diffuse, le reste de l'examen est sans particularité. Le patient rapporte que sa femme a aussi la diarrhée. Vous reprenez le diagnostic de toxi-infection alimentaire collective (TIAC), Quel (s) est (sont) l'(les) affirmation (s) en faveur de ce diagnostic ?

- A) Des cas similaires dans l'entourage.
- B) Les symptômes cliniques sont toujours digestifs.
- C) Il faut identifier un repas commun.
- D) La symptomatologie peut apparaître après 1h d'ingestion de la toxine.
- E) La fièvre est toujours présente.

Q232. TIAC

Quel est le germe le plus incriminé dans cette TIAC :

- A) Staphylococcus aureus.
- B) Yersinia enterocolitica.
- C) Clostridium botulinum.
- D) Shigella.
- E) Salmonella non typhique.

Q233. Leptospirose

Cas clinique : Ahmed vétérinaire, 35 ans sans antécédents pathologiques particuliers il est passionné d'activités aquatiques. Présente depuis 48h une fièvre à 39, céphalées, myalgies et des arthralgies. L'examen clinique trouve un ictère cutanéomuqueux et oligurie. Quel est le diagnostic le plus probable pouvez-vous évoquer chez ce patient ?

- A) Grippe saisonnière.
- B) Méningite virale.
- C) Primo infection à VIH.
- D) Leptospirose.
- E) Hépatite virale A.

Q234. Leptospirose

Quel (s) est (sont) le (s) modes de transmission de cette infection ?

- A) Inhalation de gouttelettes salivaires.
- B) Rapports sexuels non protégés.
- C) Pénétration par voie transcutanée à travers une peau fine saine.
- D) Pénétration par voie muqueuse.
- E) Ingestion d'aliments contaminés.

Q235. Leptospirose

Par quel (s) moyen (s) pouvez-vous en faire le diagnostic chez ce patient ?

- A) Test d'agglutination microscopique (MAT).
- B) Sérologie VIH.
- C) PCR Herpès Simplex Virus dans le LCR.
- D) Sérologie de l'hépatite virale A.

E) PCR leptospirose dans le sang.

Q236. Leptospirose

Quelle (s) antibiothérapie (s) curative (s) pouvez-vous prescrire chez ce patient ?

- A) Ofloxacin per os 7 jours.
- B) Amoxicilline IV 7 jours.
- C) Doxycycline per os 7 jours.
- D) Ceftriaxone IV 7 jours.
- E) Aciclovir IV 14 jours.

Q237. Infection à VIH

Cas clinique : Mme F.A âgée de 32 ans séropositive au VIH consulte pour une baisse de l'acuité visuelle depuis 3 jours. Examen clinique trouve une patiente stable sur le plan hémodynamique et respiratoire présente une candidose buccale le reste de l'examen est sans particularités. Le fond d'oeil a montré une hémorragie rétinienne en faveur d'une rétinopathie à Cytomégalovirus. Quel (s) est (sont) les antirétroviraux que vous pouvez prescrire chez cette patiente ?

- A) Valganciclovir.
- B) Fluconazole.
- C) Aciclovir.
- D) Valaciclovir.
- E) Voriconazole.

Q238. Infections à streptocoques

Cas clinique : Vous recevez une femme de 72 ans diabétique type 2 sous metformine et HTA sous amlodipine pour une douleur fébrile de la jambe droite évoluant depuis 24h. L'examen clinique montre une température 39.3 et TA 140/70mmHg FC 100/min, placard oedémateux rouge chaud induré douloureux bien limité de la jambe droite avec aspect érosif et macéré des 2 derniers espaces inter digitaux plantaire des 2 pieds. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Thrombose veineuse profonde.
- B) Dermohypodermite bactérienne non nécrosante (Erysipèle).
- C) Ecthyma.
- D) Syndrome de Stevens Johnson.
- E) Fasciite nécrosante.

Q239. Infections à streptocoques

Quel est le germe le plus probable ?

- A) Streptococcus pyogenes.
- B) Streptococcus Agalactiae.
- C) Staphylococcus Aureus.
- D) Staphylococcus à coagulase négative.
- E) Escherichia coli entérohémorragique EHEC.

Q240. Infections à streptocoques

Quels sont les 2 antibiotiques de 1ère intention ?

- A) Amoxicilline.
- B) Amoxicilline-acide clavulanique.
- C) Pénicilline G.
- D) Pénicilline M.
- E) Pristinamycine.

Q241. Infections liées aux tiques

Quels sont les 4 critères de diagnostic positif de la fièvre boutonneuse méditerranéenne ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q242. Méningites infectieuses

Quels sont les éléments cliniques, paracliniques et thérapeutiques en faveur de la méningite listérienne ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q243. Infection à VIH

Quelles sont les règles de l'annonce d'un test VIH positif ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q244. Infection à VIH

Cas clinique : Mm Z.A 35 ans séropositive au VIH, consulte aux urgences pour une dyspnée fébrile depuis 10 jours. L'examen clinique trouve une patiente consciente 15/15 fébrile à 38.5, SaO2=80%, FC=120/min, FR=30 cycle/min, une candidose buccale, le reste de l'examen clinique est sans particularité. Citez les 4 diagnostics les plus probables chez cette patiente.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q245. Infection à VIH

Quels sont les examens paracliniques à demander pour confirmer le diagnostic ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q246. Infection à VIH

Le diagnostic de pneumocystose a été retenu, quel schéma thérapeutique proposerez-vous pour cette patiente ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

EXCEPTIONNELLE 2024

Q247. Toxoplasmose

Cas clinique 1 : Une femme enceinte de 28 ans se rend à votre clinique pour une consultation prénatale. Elle est en bonne santé et c'est sa première grossesse. Elle mentionne qu'elle a récemment adopté un chat et qu'elle aime jardiner. Vous décidez de tester sa susceptibilité à la toxoplasmose. Le test le plus couramment utilisé pour évaluer l'immunité d'une femme enceinte contre la toxoplasmose est :

- A) Test PCR sur échantillon sanguin.
- B) Dosage des anticorps IgG et IgM spécifiques de *Toxoplasma gondii*.
- C) Culture de parasites à partir d'un échantillon de sang.
- D) Échographie de dépistage foetal.

Q248. Toxoplasmose

Parmi les modes de transmission suivants, lequel n'est pas une source d'infection par *Toxoplasma gondii* chez l'homme ?

- A) Ingestion de viande crue ou mal cuite contaminée.
- B) Contact direct avec un chat infecté.
- C) Ingestion d'aliments souillés par des oocystes dans le sol.
- D) Transmission verticale de la mère au fœtus.

Q249. Toxoplasmose

Quelle est la conséquence la plus grave d'une infection maternelle par *Toxoplasma gondii* au cours du premier trimestre de grossesse ?

- A) Fausse couche spontanée ou mort fœtale in utero.
- B) Retard de croissance intra-utérin.
- C) Infection asymptomatique à la naissance, avec développement normal.
- D) Risque accru de prééclampsie.

Q250. Amébose et amibes intestinales

Cas clinique 2 : Un homme de 35 ans présente depuis cinq jours une diarrhée sanglante, des douleurs abdominales diffuses, une fièvre modérée (38°C) et une fatigue. L'examen révèle une sensibilité à l'hypogastre et à la fosse iliaque droite. Il rapporte une consommation fréquente de crudités non lavées lors de ses voyages. Une Amébose intestinale est suspectée. L'agent pathogène le plus probablement responsable est ?

- A) *Giardia lamblia*.
- B) *Entamoeba histolytica*.
- C) *Balantidium coli*.
- D) *Cryptosporidium parvum*.

Q251. Amébose et amibes intestinales

Quel examen permet de confirmer le diagnostic ?

- A) Sérologie sanguine.
- B) Recherche d'antigènes parasitaires dans le sang.
- C) Examen parasitologique des selles.
- D) Biopsie intestinale.

Q252. Amébose et amibes intestinales

Quel est le mode de contamination principal de cette parasitose ?

- A) Transmission par voie aérienne.
- B) Contact direct avec une personne infectée.
- C) Ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par des kystes du parasite.
- D) Piqûre d'insecte vecteur.

Q253. Nématodoses digestives

Cas clinique 3 : Un enfant de 7 ans présente des démangeaisons anales nocturnes, des troubles du sommeil, et se gratte fréquemment. D'autres enfants de son entourage ont des symptômes similaires. Quelle est la parasitose la plus probable ?

- A) Ascarirose.
- B) Oxyurose.
- C) Toxocarose.
- D) Giardiase.

Q254. Nématodoses digestives

L'agent responsable est :

- A) *Ascaris lumbricoides*.
- B) *Enterobius vermicularis*.
- C) *Taenia saginata*.
- D) *Trichuris trichiura*.

Q255. Nématodoses digestives

Le mode de contamination se fait principalement par :

- A) Piqûre de moustique.
- B) Ingestion d'eau contaminée.
- C) Ingestion d'oeufs par contact main-bouche après contamination de l'environnement.
- D) Transmission par aérosols.

Q256. Nématodoses digestives

Quel examen permet de confirmer le diagnostic ?

- A) Examen parasitologique des selles.
- B) Frottis sanguin.
- C) Le test scotch anal.
- D) Échographie abdominale.

Q257. Plathelminthes

Cas Clinique 4 : Un homme de 40 ans consulte pour des douleurs abdominales légères et intermittentes, associées à une perte de poids inexplicable malgré un bon appétit. Il se plaint également d'un prurit anal. Un téniasis a été suspecté. Quel(s) est le parasite(s) le plus probablement responsable(s) de cette parasitose ?

- A) Taenia solium.
- B) Taenia saginata.
- C) Ascaris lumbricoides.
- D) Enterobius vermicularis.

Q258. Plathelminthes

À l'interrogatoire le patient rapporte avoir consommé régulièrement de la viande de boeuf peu cuite. Lors de l'examen, il est en bon état général. Une analyse de selles montre la présence de proglottis. Quel est le parasite le plus probablement responsable de cette parasitose ?

- A) Taenia solium.
- B) Taenia saginata.
- C) Ascaris lumbricoides.
- D) Enterobius vermicularis.

Q259. Plathelminthes

Quel élément clinique et anamnestique est en faveur de ce parasite ?

- A) Perte du poids inexplicable malgré un bon appétit.
- B) Prurit anal.
- C) Consommation de viande de boeuf peu cuite.
- D) Présence de proglottis dans les selles.

Q260. Plathelminthes

Quel examen permet de confirmer le diagnostic ?

- A) Examen microscopique des selles avec coloration de Gram.
- B) Examen direct des proglottis au microscope pour identifier les orifices génitaux latéraux.
- C) Test sérologique pour anticorps antiparasitaires.
- D) Biopsie intestinale avec examen histologique.

Q261. Dermatophytes et dermatophytoses

Cas clinique 5 : Mme S., 45 ans, diabétique de type 2, consulte pour une altération progressive des ongles des pieds. Elle décrit un épaississement et une décoloration jaunâtre de plusieurs ongles, associés à une légère douleur à la marche. L'examen montre des ongles épaissis, friables, et partiellement décollés. Une onychomycose est suspectée. Quel examen à demander pour confirmer le diagnostic ?

- A) Radiographie du pied.
- B) Examen direct au microscope et culture mycologique.
- C) Dosage des anticorps antifongiques.
- D) Biopsie de l'ongle avec examen anatomopathologique.

Q262. Dermatophytes et dermatophytoses

L'examen réalisé a permis d'identifier Trichophyton rubrum comme l'agent pathogène responsable. Trichophyton rubrum est :

- A) Une levure opportuniste.
- B) Un dermatophyte.
- C) Un bacille Gram-négatif.
- D) Un virus cutané.

Q263. Dermatophytes et dermatophytoses

Quel est le mode de contamination le plus fréquent de Trichophyton rubrum ?

- A) Transmission par l'air.
- B) Contamination par des chaussures ou des surfaces contaminées.
- C) Ingestion d'aliments contaminés.
- D) Contact avec des fluides biologiques.

Q264. Dermatophytes et dermatophytoses

Quelle mesure de prévention est recommandée pour éviter cette infection ?

- A) Utiliser des antibiotiques prophylactiques.

- B) Éviter de marcher pieds nus dans les lieux publics comme les piscines.
- C) Laver les pieds uniquement à l'eau tiède.
- D) Porter des gants lors de la manipulation des ongles.

Q265. Nématelminthes

Quelle est la complication la plus grave liée à une infection chronique par *Strongyloides stercoralis* chez une personne immunodéprimée ?

- A) Dermate éte due causée par le passage des larves.
- B) Surinfection bactérienne due à l'invasion intestinale.
- C) Syndrome d'hyperinfection avec dissémination systémique.
- D) Diarrhée chronique non compliquée.

Q266. Nématelminthes

Pourquoi l'anguillulose représente-t-elle un danger majeur chez les personnes immunodéprimées ?

- A) L'immunodépression empêche la production de larves infectieuses.
- B) Le parasite peut se multiplier de manière endogène, entraînant un syndrome d'hyperinfection.
- C) Les personnes immunodéprimées présentent une meilleure tolérance aux parasites.
- D) L'immunodépression réduit la capacité du parasite à migrer vers les poumons.

Q267. Nématelminthes

Quelle est la particularité du cycle de vie de *Strongyloides stercoralis* par rapport à d'autres helminthes ?

- A) Il nécessite obligatoirement deux hôtes pour compléter son cycle de vie.
- B) Il peut réaliser un cycle de vie libre en dehors de l'hôte humain.
- C) Il ne passe jamais par une phase larvaire infectieuse.
- D) Il meurt rapidement en l'absence d'un hôte humain.

Q268. Coccidioses intestinales

Quel est l'agent causal de la cryptosporidiose ?

- A) *Cryptosporidium parvum*.
- B) *Giardia lamblia*.
- C) *Entamoeba histolytica*.
- D) *Toxoplasma gondii*.

Q269. Coccidioses intestinales

Quel est le principal mode de transmission de *Cryptosporidium* ?

- A) Transfusion sanguine.
- B) Contact direct peau à peau.
- C) Ingestion d'eau ou d'aliments contaminés.
- D) Inhalation de spores aéroportées.

Q270. Coccidioses intestinales

Quelle est la meilleure approche de traitement pour la cryptosporidiose chez une personne immunocompétente ?

- A) Antibiothérapie agressive.
- B) Traitement antirétroviral pour les personnes séropositives au VIH.
- C) Réhydratation et gestion symptomatique.
- D) Vaccination préventive.

Q271. Leishmaniose

Quelle stratégie de prévention recommandée pour réduire le risque de transmission de la leishmaniose au Maroc ?

- A) La vaccination systématique de la population.
- B) L'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide.
- C) La prise prophylactique d'antipaludiques.
- D) La réduction des populations de phlébotomes et le contrôle des réservoirs animaux.

Q272. Méningites infectieuses

Vous recevez aux urgences une femme de 25 ans pour un syndrome méningé fébrile. Elle n'a pas d'antécédent notable. Elle présente depuis 3 jours une pharyngite érythémateuse sans amygdalite, avec une fièvre à 38,6°C. L'examen physique à l'arrivée montre : T=39°, FC=100/min, PA=100/60 mm Hg, FR=16 cycles/min ; Somnolence, obnubilation ; Macules violacées ne s'effaçant pas à la vitro pression ; Raideur méningée. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Méningite à Méningocoque.
- B) Méningite à Pneumocoque.
- C) Méningite Virale.
- D) Méningite Tuberculeuse.
- E) Méningite Listérienne.

Q273. Méningites infectieuses

Vous réalisez une ponction lombaire. Quels sont les résultats attendus ?

- A) Liquide clair.
- B) Pléiocytose à prédominance polynucléaire neutrophiles.
- C) Protéinorachie < 1g/L.
- D) Rapport glycorachie / glycémie < 0.5.
- E) Il est possible de rechercher le germe par PCR.

Q274. Méningites infectieuses

Les résultats du LCR confirment votre suspicion. Quel (s) traitement (s) administrez-vous ?

- A) Dexaméthasone.
- B) Aciclovir.
- C) Amoxicilline-Acide clavulanique.
- D) Ceftriaxone.
- E) Gentamicine.

Q275. Méningites infectieuses

Concernant la prise en charge des sujets contacts, quelle (s) est (sont) l'(les) affirmation(s) exacte(s) ?

- A) Déclaration obligatoire.
- B) Vaccination selon le sérotype.
- C) Antibio prophylaxie par rifampicine.
- D) Antibio prophylaxie par amoxicilline.
- E) Pas de traitement de prophylaxie.

Q276. AES

Concernant les accidents d'exposition au sang, quelles sont les situations associées à un risque important de transmission du VIH ?

- A) Piqûre avec une aiguille creuse.
- B) Piqûre avec un dispositif intravasculaire.
- C) Piqûre avec une aiguille IM.
- D) Piqûre avec une aiguille SC.
- E) Piqûre avec une seringue abandonnée.

Q277. AES

Dans quels délais le traitement antirétroviral post exposition peut-il être mis en route ?

- A) Moins de 4h après l'exposition à risque.
- B) 4 à 12h après l'exposition à risque.
- C) 24 à 48h après l'exposition à risque.
- D) 12 à 72h après l'exposition à risque.
- E) 12 à 96h après l'exposition à risque.

Q278. AES

En cas d'accident d'exposition au sang, quelle (s) est (sont) la (les) mesure(s) de protection vis-à-vis du risque VHC ?

- A) Vaccination anti VHC.
- B) Administrations d'immunoglobulines spécifiques.
- C) Traitement immunomodulateur prophylactique par interféron pégylé.
- D) Traitement antiviral post exposition.
- E) Il n'existe pas de prophylaxie vis-à-vis du risque VHC.

Q279. TIAC

Vous recevez en urgences Mr A.H âgé de 58 ans HTA sous Ramipril et diabétique type 2 sous régime seul qui consulte pour des diarrhées liquidiennes d'installation brutale sans sang ni glaires. Le patient rapporte que sa femme a aussi la diarrhée. Vous reprenez le diagnostic de toxi-infection alimentaire collective (TIAC). Quel (s) est (sont) l'(les) affirmation(s) en faveur de ce diagnostic ?

- A) Des cas similaires dans l'entourage.
- B) Les symptômes cliniques sont toujours digestifs.
- C) Il faut identifier un repas commun.
- D) La symptomatologie peut apparaître après 1h d'ingestion de la toxine.
- E) La fièvre est toujours présente.

Q280. TIAC

Quel est le germe le plus incriminé dans cette TIAC ?

- A) Staphylococcus aureus.
- B) Yersinia enterocolitica.
- C) Clostridium botulinum.
- D) Shigella.
- E) Salmonella non typhique.

Q281. Leptospirose

Cas clinique : Ahmed vétérinaire, 35 ans sans antécédents pathologiques particuliers il est passionné d'activités aquatiques. Présente depuis 48h une fièvre à 39°C, céphalées, myalgies et des arthralgies. L'examen clinique trouve un ictère cutanéomuqueux et oligurie. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Grippe saisonnière.
- B) Méningite virale.
- C) Primo-infection à VIH.
- D) Leptospirose.
- E) Hépatite virale A.

Q282. Leptospirose

Quel (s) est (sont) le (s) mode(s) de transmission de cette infection ?

- A) Inhalation de gouttelettes salivaires.
- B) Rapports sexuels non protégés.
- C) Pénétration par voie transcutanée à travers une peau fine saine.
- D) Pénétration par voie muqueuse.

E) Ingestion d'aliments contaminés.

Q283. Leptospirose

Par quel (s) moyen (s) pouvez-vous en faire le diagnostic chez ce patient ?

- A) Test d'agglutination microscopique (MAT).
- B) Sérologie VIH.
- C) PCR Herpès Simplex Virus dans le LCR.
- D) Sérologie de l'hépatite virale A.
- E) PCR leptospirose dans le sang.

Q284. Leptospirose

Quelle (s) antibiothérapie (s) curative (s) pouvez-vous prescrire chez ce patient ?

- A) Ofloxacin per os 7 jours.
- B) Amoxicilline IV 7 jours.
- C) Doxycycline per os 7 jours.
- D) Ceftriaxone IV 7 jours.
- E) Aciclovir IV 14 jours.

Q285. Infection à VIH

Cas clinique : Mme F.A âgée de 32 ans séropositive au VIH consulte pour une baisse de l'acuité visuelle depuis 3 jours. L'examen du fond d'oeil a montré une hémorragie rétinienne en faveur d'une rétinite à Cytomégalovirus. Quel (s) est (sont) les antiviraux que vous pouvez prescrire chez cette patiente ?

- A) Valganciclovir.
- B) Fluconazole.
- C) Aciclovir.
- D) Valaciclovir.
- E) Voriconazole.

Q286. Infections à streptocoques

Cas clinique : Vous recevez une femme de 72 ans diabétique type 2 sous metformine et HTA sous amlodipine pour une douleur fébrile de la jambe droite évoluant depuis 24h. L'examen clinique montre une température 39.3, un placard oedémateux rouge chaud induré douloureux bien limité de la jambe droite avec aspect érosif et macéré des 2 derniers espaces interdigitaux. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Thrombose veineuse profonde.
- B) Dermohypodermite bactérienne non nécrosante.
- C) Ecthyma.
- D) Syndrome de Stevens Johnson.
- E) Fasciite nécrosante.

Q287. Infections à streptocoques

Quel est le germe le plus probable ?

- A) Streptococcus pyogenes.
- B) Streptococcus Agalactiae.
- C) Staphylococcus Aureus.
- D) Staphylococcus à coagulase négative.
- E) Escherichia coli entérohémorragique EHEC.

Q288. Infections à streptocoques

Quels sont les 2 antibiotiques de 1ère intention ?

- A) Amoxicilline.
- B) Amoxicilline-acide clavulanique.
- C) Pénicilline G.
- D) Pénicilline M.
- E) Pristinamycine.

Q289. Infections liées aux tiques

Quels sont les 4 critères de diagnostic positif de la fièvre boutonneuse méditerranéenne ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q290. Méningites infectieuses

Quels sont les éléments cliniques, paracliniques et thérapeutiques en faveur de la méningite listérienne ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q291. Infection à VIH

Quelles sont les règles de l'annonce du test VIH positif ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q292. Infection à VIH

Cas clinique : Mm Z.A 35 ans séropositive au VIH, consulte aux urgences pour une dyspnée fébrile depuis 10 jours. L'examen clinique trouve une patiente consciente 15/15 fébrile à 38.5, SaO₂=80%, FC=120/min, FR=30cycle /min, une candidose buccale, le reste de l'examen clinique est sans particularité. Citez les 4 diagnostics les plus probables chez cette patiente :

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q293. Infection à VIH

Quels sont les examens paracliniques à demander pour confirmer le diagnostic ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q294. Infection à VIH

Le diagnostic de pneumocystose a été retenu, quel schéma thérapeutique proposerez-vous pour cette patiente ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

RATTRAPAGE 2023

Q295. Paludisme P

Cas clinique 1 : Il s'agit d'un patient de 65 ans, consultant initialement aux urgences pour hémorragie digestive, où il a été hospitalisé et transfusé de quatre culots globulaires provenant de 4 donneurs différents. Il consulte dans une clinique privée pour fièvre brutale à 39°C suscitant une nouvelle hospitalisation. Un frottis sanguin/Goutte épaisse sont demandés dans le cadre d'un diagnostic d'exclusion et reviennent positifs à Plasmodium vivax.

Citer les différentes espèces du Plasmodium affectant l'Homme. Citer les deux espèces caractérisées par les rechutes tardives, Et expliquer le mécanisme de ces rechutes. Est-il le cas (possibilité de rechute tardive) pour votre patient ? Argumenter votre réponse.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q296. Nématelminthes

Cas clinique 2 : Une fillette de 5ans est amenée en consultation pour un prurit vulvaire avec des leucorrhées associées à la notion de démangeaisons anales nocturnes.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Oxyurose.
- B) Amoebose.
- C) Bilharziose urogénitale.
- D) Trichomonose vaginale.
- E) Candidose.

Q297. Nématodoses digestives

Quelle (s) est (sont) la (les) caractéristique (s) de l'agent responsable de l'oxyurose :

- A) Un cestode.
- B) Est transmis par un vecteur.
- C) Ses oeufs directement infestants à la ponte.
- D) Sa femelle est hématophage.

Q298. Hydatidose

Quelles sont les deux complications auxquelles expose la ponction d'un kyste hydatique ?

- A) Une fibrose hépatique.
- B) Obstacle à l'écoulement hépatique.
- C) Anémie ferriprive.
- D) Une dissémination péritonéale.
- E) Un choc anaphylactique.

Q299. Amoebose et amibes intestinales

L'amoebose intestinale :

- A) Est due à un Rhizopode.
- B) Est responsable d'atteinte extra intestinale.
- C) Est responsable d'une malabsorption lipidique.
- E) Est évoquée devant la présence du sang dans les selles.

Q300. Amoebose et amibes intestinales

Quel est l'agent responsable de l'amoebose intestinale ?

- A) Endolimax nana.
- B) Entamoeba coli.
- C) Entamoeba dispar.
- E) Entamoeba histolytica.

Q301. Toxoplasmose

Quel est le facteur qui influence directement le risque de gravité d'une toxoplasmose congénitale ?

- A) L'âge de la mère.
- B) L'âge de la grossesse.
- C) La notion de voyage.
- D) La prise de corticoïde.

E) La présence de chien dans l'entourage.

Q302. Flagelloses intestinales et uro-génitales

Giardia intestinalis :

- A) Est un cestode.
- B) Est responsable d'atteinte extra intestinale.
- C) Est évoquée devant la présence du sang dans les selles.
- D) Est responsable d'un retard staturo- pondéral.
- E) Est responsable d'une malabsorption intestinale.

Q303. Leptospirose

Parmi les éléments suivants, indiquez celui ou ceux qui vous paraît (paraissent) évocateurs de la leptospirose ?

- A) Ictère.
- B) Insuffisance rénale.
- C) Méningite purulente.
- D) Hyperleucocytose.
- E) Thrombopénie.

Q304. Leptospirose

Parmi les examens complémentaires suivants lequel permet de poser en routine le diagnostic de la leptospirose ?

- A) L'hémoculture.
- B) Le Western blot.
- C) Le Test d'agglutination microscopique (MAT).
- D) L'antigénémie.
- E) La bandelette urinaire.

Q305. Antibiotiques

Quelles sont les caractéristiques des fluoroquinolones :

- A) Indiquées dans l'infection urinaire.
- B) Bactériostatiques.
- C) Spectre étroit.
- D) Mauvaise diffusion tissulaire.
- E) Indiqués chez l'enfant de 8 ans.

Q306. Méningites infectieuses

Devant un liquide céphalo-rachidien purulent, vous retenir en faveur d'une méningite à Pneumocoque :

- A) Purpura.
- B) Notion d'épidémie.
- C) Antécédent de traumatisme crânien.
- D) Atteinte des nerfs crâniens.
- E) Otite aiguë.

Q307. Septicémies à staphylocoques

Le staphylocoque peut être responsable de manifestations suivantes :

- A) Scarlatine.
- B) Abscess pulmonaire.
- D) Ostéomyélite aiguë.
- E) Furunculose.

Q308. Rage

Le virus de la rage peut être transmis à l'homme par :

- A) Manipulation d'un chien mort.
- B) Morsure par un patient enragé.
- C) Léchage de plaie par un chien enragé.
- D) Voie aérienne par inhalation dans les grottes.
- E) Contamination du personnel de laboratoire.

Q309. Rage

La symptomatologie de la rage est expliquée par :

- A) Fixation d'une toxine sur le système nerveux.
- B) Diffusion du germe dans le sang.
- C) Atteinte des méninges.
- D) Localisation du germe au niveau de l'hippocampe.
- E) Réactivation du virus qui était en état de latence.

Q310. Rage

Le risque de contamination par le virus de la rage est plus élevé en cas de :

- A) Morsure par un animal errant.
- B) Morsure au niveau des mains.
- C) Morsure au niveau d'une peau lésée.
- D) Morsure par un chien vacciné.
- E) Léchage sur une peau intacte.

Q311. Méningites infectieuses

La coexistence d'un syndrome méningé fébrile avec une réaction cellulaire lymphocytaire et des signes d'atteinte de la base du crâne vous oriente vers :

- A) Une méningite à Pneumocoque.
- B) Une méningite à Listéria.
- C) Une méningite Tuberculeuse.
- D) Une méningite à Méningocoque.
- E) Une méningite à Hémophiles.

Q312. Méningites infectieuses

Les arguments en faveur d'une méningo-encéphalite herpétique comportent :

- A) Hypoglycorachie.
- B) Trouble du comportement.
- C) Présence de globules rouges dans le LCR.
- D) Immunodépression ?
- E) Atteinte des paires crâniennes.

Q313. Infections liées aux tiques

Devant une éruption cutanée évocatrice d'une fièvre boutonneuse méditerranéenne, quelles sont les autres infections à évoquer ?

- A) Syphilis secondaire.
- B) Fièvre typhoïde.
- C) Infection à méningocoque.
- D) Bactériémie à Staphylocoque.
- E) Primo-infection à VIH.

Q314. Infections liées aux tiques

Le traitement de première intention de la fièvre boutonneuse méditerranéenne repose sur ?

- A) Pénicilline A.
- B) Cyclines.
- C) Céphalosporines de 3ème génération.
- D) Macrolides.
- E) Métronidazole.

Q315. TIAC

Concernant la symptomatologie habituelle de la toxi-infection alimentaire à Salmonelle de l'adulte jeune, retenez les faits exacts :

- A) Incubation courte < 12 heures de l'ingestion de l'aliment.
- B) Syndrome dysentérique.
- C) Hyperthermie.
- D) Vomissements.
- E) Diarrhée cholériforme.

Q316. Infection à VIH

Concernant la primo-infection à VIH retenez les propositions exactes :

- A) La charge virale est indétectable.
- B) La réplication virale est intense.
- C) Le risque de transmission virale est faible.
- D) Le taux des CD4 est bas.
- E) La sérologie VIH est négative.

Q317. Infection à VIH

Parmi les signes suivants, quels sont ceux que vous retrouvez lors de la primo-infection à VIH :

- A) Éruption cutanée.
- B) Sarcome de Kaposi.
- C) Diarrhée chronique.
- D) Ulcérations génitales.
- E) Méningite lymphocytaire.

Q318. Infection à VIH

Le diagnostic de la coinfection VIH - Tuberculose au stade avancé de l'immunodépression repose sur :

- A) L'intradermoréaction à la tuberculine.
- B) Le Quantiféron -TB.
- C) L'isolement de BK dans les expectorations.
- D) Le gene-xpert dans les expectorations.
- E) Biopsie ganglionnaire ?

Q319. Infection à VIH

Indiquez la ou les propositions exactes concernant le ganciclovir (Cymevan®) :

- A) Il agit par inhibition de la synthèse de l'ADN viral.
- B) Il agit sur les herpès simplex virus de type 1 et 2 et sur le cytomégalovirus.
- C) Nécessite la surveillance du taux des PNN.
- D) Indiqué dans l'oesophagite à cytomégalovirus.
- E) C'est le traitement de référence de la méningo-encéphalite herpétique.

Q320. Méningites infectieuses

Une méningite à liquide clair peut être causée par une infection à :

- A) Streptococcus pneumoniae.
- B) Mycobacterium tuberculosis.
- C) Herpès simplex virus.
- D) Neisseria meningitidis.
- E) Listeria monocytogenes.

Q321. AES

Cas clinique : Un médecin a été victime d'un accident d'exposition au sang (AES) suite à une piqure par une aiguille creuse lors d'un prélèvement sanguin. La piqure est survenue au niveau de son 3ème doigt alors qu'il ne portait pas de gants. En examinant le doigt, on a trouvé une plaie profonde de 3 mm qui saigne.

Quels sont les premiers soins d'urgence que ce médecin doit faire dans les 5 premières minutes ? Selon la nature de cette plaie et l'instrument utilisé, comment vous évaluez le risque encouru par le médecin ? Argumentez. Quel bilan initial faut-il faire à la personne source et au chirurgien ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q322. Infections à streptocoques

Cas clinique : Un jeune de 14 ans présente une poussée de rhumatisme articulaire aigu ayant compliqué un épisode d'angine insuffisamment traitée

Préciser le traitement curatif et préventif dans la prise en charge de ce patient. Citez une complication redoutable du rhumatisme articulaire aigu (RAA).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q323. Tétanos

Cas clinique : Un patient de 50 ans, victime d'une blessure par objet tranchant au niveau du pied. L'interrogatoire trouve que le dernier rappel du vaccin antitétanique remonte à 20 ans.

Quel est le schéma de la vaccination antitétanique que vous proposez au patient ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q324. Infection à VIH

Quelles sont les indications du dépistage obligatoire du VIH ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q325. Septicémies à staphylocoques

Citez les critères du Score rapide (Quick SOFA) pour retenir le diagnostic du sepsis.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q326. Septicémies à staphylocoques

Citez 3 complications à redouter en cas de staphylococcie maligne de la face.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q327. Paludisme P

Citez 5 critères de gravité du paludisme.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q328. Méningites infectieuses

Devant un syndrome méningé, citez 3 indications du scanner cérébral avant de faire la ponction lombaire.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

NORMALE 2023

Q329. Toxoplasmose

Cas clinique 1 : Madame X Primigeste au 5ème mois de Grossesse, vous apporte les résultats de ses sérologies de la toxoplasmose. IgG anti toxoplasme = 0 UI/ml (ELISA, seuil de positivité 8). IgM anti toxoplasme = 1,2UI/ml (ELISA, seuil de positivité = 0,65). Comment interprétez- vous les résultats de cette sérologie et Quel est votre attitude ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q330. Toxoplasmose

Les résultats d'une nouvelle sérologie réalisée dans le même laboratoire un mois après : IgG anti toxoplasme= 0 UI/ml (ELISA, seuil de positivité 8). IgM anti toxoplasme= 0,2UI/ml (ELISA, seuil de positivité = 0,65). Comment interprétez - vous les résultats de cette

sérologie et quel est votre attitude ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q331. Toxoplasmose

Le résultat des sérologies demandées au 7ème mois de grossesse : IgG anti toxoplasme= 14 UI/ml (ELISA, seuil de positivité 8). IgM anti toxoplasme= 20 UI/ml (ELISA, seuil de positivité = 0,65). Comment interprétez- vous l'évolution sérologique observée sur ce sérum et quelle est la suite de la prise en charge ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q332. Toxoplasmose

L'accouchement s'est bien déroulé, un garçon dont l'examen clinique est normal. Le résultat des sérologies du nouveau-né est : IgG anti toxoplasme= 120 UI/ml (ELISA, seuil de positivité 8). IgM anti toxoplasme= 0,2 UI/ml (ELISA, seuil de positivité = 0,65). Comment interprétez- vous les résultats de cette sérologie et Quel est votre attitude ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q333. Paludisme P

Cas clinique 2 : Il s'agit d'un patient de 65 ans, consultant initialement aux urgences pour hémorragie digestive, où il a été hospitalisé et transfusé de quatre culots globulaires provenant de 4 donneurs différents. Il consulte dans une clinique privée pour fièvre brutale à 39°C suscitant une nouvelle hospitalisation. Un frottis sanguin/Goutte épaisse sont demandés dans le cadre d'un diagnostic d'exclusion et reviennent positifs à Plasmodium vivax. Citer les différentes espèces du Plasmodium affectant l'Homme.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q334. Paludisme P

Citer les deux espèces caractérisées par les rechutes tardives, et expliquer le mécanisme de ces rechutes.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q335. Paludisme P

Est-il le cas (possibilité de rechute tardive) pour votre patient ? Argumenter votre réponse.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q336. Coccidioses intestinales

Cas clinique 3 : Un Homme de 3 ans se présente à la consultation pour une diarrhée liquidienne, persistante depuis un mois associé à une altération de l'état général (amaigrissement de 10kg). La sérologie VIH est positive. Quelles sont les parasitoses intestinales les plus probables ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q337. Coccidioses intestinales

Les examens parasitologiques standards des selles demandées trois fois étaient négatifs. Quel est votre attitude ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q338. Leishmaniose

Citer les réservoirs de parasite de la leishmaniose au Maroc.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q339. Introduction à la parasitologie médicale

Quels sont les deux agents étiologiques responsables de la Trypanosome Africaine ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q340. Fièvre typhoïde

Parmi les éléments suivants, indiquez celui ou ceux qui vous paraît (paraissent) évocateurs de la fièvre typhoïde ?

- A) Éruption vésiculeuse.
- B) Dysphagie.
- C) Température en plateau.
- D) Douleurs articulaires.
- E) Splénomégalie.

Q341. Fièvre typhoïde

Parmi les examens complémentaires suivants le ou lesquels permettent de poser avec certitude le diagnostic de fièvre typhoïde ?

- A) Hémogramme.
- B) Recherche de l'Ag soluble urinaire.
- C) Coproculture.
- D) Hémoculture.
- E) Intradermoréaction avec l'antigène spécifique.

Q342. Antibiotiques

Les céphalosporines de troisième génération sont :

- A) Des bêta-lactamines.
- B) Actifs sur les entérobactéries.
- C) Toutes actives sur *Pseudomonas aeruginosa*.
- D) Indiquées dans la méningite à *Listeria*.
- E) Indiquées dans l'endocardite bactérienne.

Q343. Méningites infectieuses

Devant un liquide céphalo-rachidien purulent, vous retenez en faveur d'une méningite à méningocoque :

- A) Notion d'épidémie.
- B) Antécédent de traumatisme crânien.
- C) Atteinte des nerfs crâniens.
- D) Oto-mastoidite récente.
- E) Association à un purpura pétéchial.

Q344. Infections à streptocoques

Le streptocoque peut être responsable de dermatoses suivantes :

- A) Erysipèle.
- B) Scarlatine.
- C) Impétigo.
- D) Erythème noueux.
- E) Furunculose.

Q345. Tétanos

La symptomatologie du tétanos peut être causée par :

- A) La diffusion du germe dans le sang.
- B) Un trouble métabolique.
- C) La localisation du germe au niveau de l'encéphale.
- D) La fixation d'une toxine sur le système nerveux.
- E) Aucune de ces propositions.

Q346. Tétanos

A propos du tétanos :

- A) Le trismus est un signe tardif.
- B) Un accès paroxystique de contracture peut être déclenché par un acte thérapeutique douloureux.
- C) Le pronostic est meilleur si le temps d'invasion est court.
- D) Le vaccin antitétanique doit être associé au sérum antitétanique.
- E) Le vaccin antitétanique donne une immunité définitive.

Q347. Rage

En cas de morsure grave par un animal suspect de rage :

- A) Il faut suturer rapidement les plaies de morsure.
- B) Il faut tuer aussitôt l'animal mordeur.
- C) La vaccination antirabique doit être appliquée.
- D) Les immunoglobulines sont indiquées dans ce cas.
- E) La vaccination antitétanique est indiquée.

Q348. Fièvre typhoïde

Parmi les examens complémentaires suivants, le ou lesquels vous paraissent indispensables dans l'examen initial d'une fièvre évoluant depuis 21 jours ?

- A) Radiographie du thorax.
- B) Numération sanguine de formule leucocytaire.
- C) Urographie intraveineuse.
- D) Echographie abdominale.
- E) TDM abdominale.

Q349. Méningites infectieuses

La coexistence d'un syndrome méningé fébrile avec une réaction cellulaire panachée (lymphocytes et polynucléaires) et des signes d'atteinte de la région bulbo-protubérantielle vous oriente vers :

- A) Une méningite à *Pneumocoque*.
- B) Une méningite à *Listeria*.
- C) Une méningite brucellienne.
- D) Une méningite à méningocoque.
- E) Une méningite à Hémophiles.

Q350. Méningites infectieuses

Les arguments en faveur d'une méningite tuberculeuse comportent :

- A) Atteinte de l'état général.
- B) Hypoglycorachie.
- C) LCR hémorragique.
- D) Sujet transplanté.
- E) Atteinte des paires crâniennes.

Q351. Leptospirose

Au cours de la Leptospirose :

- A) L'atteinte rénale est en rapport avec une néphrite tubulo-interstitielle.
- B) L'ictère est un des signes constants.
- C) L'atteinte pulmonaire est un élément de mauvais pronostic.
- D) La méningite est liée à la présence de *Leptospira* dans les méninges.
- E) La diurèse est toujours conservée.

Q352. Infections liées aux tiques

Quels éléments caractérisent l'éruption de la fièvre boutonneuse méditerranéenne ?

- A) Éruption bulleuse.
- B) Évolution descendante.
- C) Entraîne une fine desquamation.
- D) Éruption maculo-papuleuse.
- E) Début derrière les oreilles.

Q353. Septicémies à staphylocoques

L'ostéomyélite aiguë des membres du grand enfant se manifeste habituellement à son début par :

- A) Une fièvre élevée.
- B) Une douleur locale d'intensité modérée.
- C) Une impotence fonctionnelle.
- D) Une absence d'anomalie radiologique.
- E) Un risque de fracture de l'os.

Q354. Infections à streptocoques

Parmi les signes suivants, indiquez celui ou ceux qui sont caractéristiques de la scarlatine :

- A) Aspect souffleté du visage.
- B) Éruption maculopapuleuse avec intervalle de peau saine.
- C) Réaction ganglionnaire cervicale.
- D) Langue framboisée.
- E) Angine érythémateuse.

Q355. Antibiotiques

Le type et le mode d'action des bêta-lactamines est caractérisé par :

- A) Bactériostase.
- B) Bactéricidie.
- C) Inhibition des synthèses protéiques bactériennes.
- D) Inhibition de la synthèse de paroi des bactéries en phase de croissance.
- E) Altération de la membrane cytoplasmique.

Q356. Choléra

Concernant la symptomatologie habituelle du choléra de l'adulte jeune, retenir les faits exacts :

- A) Incubation de quelques heures.
- B) Syndrome dysentérique.
- C) Hyperthermie.
- D) Déshydratation sévère.
- E) Polyurie.

Q357. Antibiotiques

Indiquez la ou les propositions exactes concernant l'acycloguanosine ou acyclovir (Zovirax®) :

- A) Il est actif sur le Cytomégalovirus.
- B) Il agit par inhibition de la synthèse de l'ADN viral.
- C) Il agit sur les herpès simplex virus de type 1 et 2 et sur le virus de la varicelle et du zona.
- D) La voie orale est indiquée dans l'encéphalite herpétique.
- E) Nécessite une adaptation de la posologie en cas d'insuffisance rénale.

Q358. Fièvre typhoïde

Cas clinique : Un éleveur de bétail, âgé de 43 ans, hospitalisé pour une fièvre prolongée au décours d'un syndrome pseudo-grippal, sans altération de l'état général. Il se plaint de sueurs, de myalgies diffuses, de rachialgies et d'une douleur testiculaire bilatérale. Ces données cliniques :

- A) Permettent d'exclure une brucellose aiguë.
- B) Peuvent correspondre à une brucellose aiguë.
- C) Peuvent correspondre à une brucellose subaiguë.
- D) Sont caractéristiques d'une brucellose à la phase chronique.
- E) Sont caractéristiques d'une autre étiologie infectieuse qu'une brucellose.

Q359. Antibiotiques

Quel(s) est (sont) le (les) schéma(s) thérapeutique(s) pouvant être prescrit(s) dans le traitement de ce cas ?

- A) Céphalosporine + Gentamicine.
- B) Ampicilline + Gentamicine.
- C) Cyclines + Gentamicine.
- D) Ciprofloxacine + Streptomycine.
- E) Cyclines + Streptomycine.

Q360. Septicémies à staphylocoques

Au cours d'une septicémie à staphylocoque, préciser la principale localisation secondaire à craindre ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q361. Septicémies à staphylocoques

Proposer le traitement antibiotique (nature et durée) d'une septicémie à *Staphylococcus aureus* communautaire non compliquée de localisations secondaires, chez un adulte non taré.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q362. Méningites infectieuses

Cas clinique : Un jeune étudiant de 20 ans, suivi pour drépanocytose hétérozygote, splénectomisé, consulte aux urgences pour des céphalées en casque rebelles aux antalgiques, des vomissements incoercibles et une photophobie. A l'examen : patient fébrile à 39,5°C, couché en « chien de fusil », raideur de la nuque avec présence des signes de Kernig et de Brudzinski. La ponction lombaire a ramené un LCR trouble contenant 1300 éléments (90% polynucléaires neutrophiles), une glucorachie à 0,30 mg/l (glycémie à 1,80 g/l) et une protéinorachie à 4 g/l. L'examen direct montre des cocci Gram positif. Interpréter les données de la ponction lombaire.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q363. Méningites infectieuses

Quel est le germe responsable de la méningite ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q364. Méningites infectieuses

Quelle antibiothérapie de première intention allez-vous prescrire (molécule, posologie) ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q365. Méningites infectieuses

Quelle est la mesure préventive à envisager chez ce patient ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q366. Infection à VIH

Cas clinique : Patient âgé de 26 ans consulte pour toux, altération de l'état général et fièvre évoluant depuis 2 mois. Ce patient a de multiples relations sexuelles non protégées. A l'examen, il présente une candidose buccale, une dermite séborrhéique du visage et de rares râles crépitants à l'auscultation pulmonaire. La radiographie de thorax montre des opacités interstitielles diffuses. A la biologie = GB: 4200/mm³, Polynucléaires neutrophiles: 3000/mm³ et lymphocytes : 700/mm³. Vous suspectez le diagnostic d'une infection par le VIH. Relever, à partir de l'énoncé les éléments épidémiologiques, cliniques et biologiques orientant vers l'infection par le VIH ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q367. Infection à VIH

Devant la symptomatologie pulmonaire clinique et radiologique, citer les 2 principales infections opportunistes à évoquer.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q368. Infection à VIH

Le taux de CD4 est à 120 éléments/mm³. Citer ces 2 infections opportunistes non bactériennes qui nécessitent une chimioprophylaxie primaire à ce stade.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q369. Infection à VIH

Préciser la nature de la molécule à prescrire.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q370. Rage

Cas clinique : Un enfant âgé de cinq ans vous consulte pour des lésions délabrantes du visage secondaires à des morsures par un chien errant. Quel schéma vaccinal à proposer pour prévenir la rage ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q371. Paludisme MI

Cas clinique : Un ingénieur âgé de 35 ans, sans antécédents pathologiques, va se rendre au Sénégal pour une durée de deux mois dans le cadre de son travail. Quelle chimioprophylaxie antipalustre (molécule, dose, durée) prescrivez-vous sachant que le Sénégal fait partie de la zone C ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q372. Toxoplasmose

Devant une suspicion de toxoplasmose congénitale chez un nouveau né dont la mère a présenté une séroconversion en cours de grossesse une sérologie de toxoplasmique est effectuée sur le sang de cordon et montre : IgG = 300UI/ml (seuil = 6UI/ml) IgM : Absence. Quel autre examen sérologique est indiqué pour confirmer ce diagnostic ? Quel est le principe de ce test ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q373. Coccidioses intestinales

Un patient de 25ans infecté par le VIH consulte pour une diarrhée liquidienne apparue il y a 4 mois, sans glaires, ni fièvre. Vous suspectez une parasitose intestinale opportuniste. Quels sont les parasites que vous recherchez dans ce cas ?

- A) Cryptosporidium.
- B) Cyclospora.
- C) Isospora.
- D) Giardia intestinalis.
- E) Endolimax nana.

Q374. Coccidioses intestinales

Dans la continuité du cas précédent, l'examen direct à l'état frais des selles a montré des éléments allongés en obus mesurant de 25 - 35 μ / 10-15 μ . De quel parasite s'agit-il ? Quelle est la forme parasitaire mise en évidence dans les selles ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q375. Nématodoses digestives

Cas clinique 3 : une fillette de 5ans est amenée en consultation pour un prurit vulvaire avec des leucorrhées ; l'interrogatoire révèle la notion de prurit anal nocturne. Quel est le diagnostic le plus probable ? Quel est le mode de contamination de cette parasitose ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q376. Leishmaniose

Citer deux formes cliniques de leishmaniose cutanée au Maroc, quels sont les espèces de leishmanies associées à ces deux formes cliniques ? Et Quels sont leur réservoir ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q377. Paludisme MI

Expliquer le phénomène de cytoadhérence du Plasmodium falciparum et sa conséquence clinique.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q378. Amoebose et amibes intestinales

Entamoeba histolytica :

- A) Est un Protozoaire flagellé.
- B) Est différencié microscopiquement d'Entamoeba dispar.
- C) Est différencié microscopiquement d'Entamoeba coli.
- D) Est strictement intraluminale.
- E) Est responsable de lésions invasives par le biais de ses kystes.

Q379. Coccidioses intestinales

Les étapes du cycle évolutif d'un Apicomplexa sont (une seule proposition est juste) :

- A) Oocyste- Sporozoïte- Mérozoïte- Gamètes.
- B) Kyste- Sporozoïte- Mérozoïte- Gamètes.
- C) Kyste- Oocyste- Mérozoïte- Sporozoïte.
- D) Promastigote- Amastigote- Kyste.

Q380. Méningites infectieuses

Quels sont les signes cliniques caractéristiques de la méningo-encéphalite herpétique ?

- A) Strabisme convergent.
- B) Hallucinations visuelles.
- C) Troubles du langage.
- D) Contractures musculaires.
- E) Lésions purpuriques.

Q381. Paludisme MI

Patient âgé de 34 ans, chauffeur de profession, revient d'un voyage du Mali il y a 5 jours et qui se présente pour une fièvre avec vomissements. La goutte épaisse est positive au Plasmodium falciparum. Quel est le traitement qu'on doit prescrire au patient ?

- A) Artéméter - Luméfantrine (Coartem*) VO.
- B) Artésunate (Artesun*) IV.
- C) Chloroquine (Nivaquine*) VO.
- D) Quinine (Quinimax*) IV.
- E) Méfloquine (Lariam®) VO.

Q382. Paludisme MI

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des critères de gravité du paludisme ?

- A) Parasitémie à 6%.
- B) Taux d'hémoglobine à 12 g/dl.
- C) Taux des plaquettes à 70 000 éléments/mm³.
- D) Tension artérielle systolique (TAS < 70 mm Hg).
- E) Détresse respiratoire.

Q383. Leptospirose

Quels sont les signes cliniques en faveur de la Leptospirose ?

- A) Eruption cutanée généralisée.
- B) Epistaxis.
- C) Dissociation pouls- température.
- D) Oligurie.
- E) Syndrome méningé.

Q384. Leptospirose

Le diagnostic de la leptospirose à la phase ictérique repose sur :

- A) Hémoculture.
- B) Sérodiagnostic de Martin et Petit (MAT).
- C) Examen direct au microscope à fond noir.
- D) Polymérase chaîne réaction (PCR).
- E) Culture sur des milieux spéciaux.

Q385. Infection à VIH

Parmi les propositions suivantes, la ou lesquelles correspondent à la primo-infection à VIH ?

- A) La période la plus longue de l'histoire naturelle du VIH.
- B) Le risque de transmission interhumaine est minime.
- C) Le diagnostic précoce se fait par la sérologie VIH ELISA.
- D) Le traitement antirétroviral (ARV) n'est pas indiqué à ce stade.
- E) Peut se manifester par une éruption fébrile.

Q386. Infection à VIH

Patient âgé de 34 ans, admis pour un flou visuel, une baisse récente de l'acuité visuelle de l'oeil droit avec candidose buccale et altération de l'état général. Le fond d'oeil a montré des exsudats avec nécrose hémorragique et la sérologie VIH est positive avec un taux des CD4 à 30 cellules/mm³. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Chorio-rétinite toxoplasmique.
- B) Rétinite à cytomégalovirus CMV.
- C) Rétinite au VIH.
- D) Rétinite à herpès virus (VZV).
- E) Rétinite syphilitique.

Q387. Infection à VIH

Dans la continuité du cas précédent, quel est la ou les molécules qu'on doit prescrire au patient ?

- A) Acyclovir.
- B) Ganciclovir.
- C) Valganciclovir.
- D) Cotrimoxazole.
- E) Cortancyl.

Q388. Méningites infectieuses

Quels sont les signes cliniques en faveur de la méningo-encéphalite tuberculeuse ?

- A) Syndrome méningé d'installation brutale.
- B) Purpura.
- C) Trouble de conscience.
- D) Strabisme convergent.
- E) Otite purulente.

Q389. Méningites infectieuses

Quels sont les éléments paracliniques en faveur de la méningite tuberculeuse ?

- A) Lymphopénie à la NFS.
- B) Hyponatrémie.
- C) Hypoglycorachie (LCR).
- D) Hyperleucocytose à la NFS.
- E) Miliaire radiologique.

Q390. Cryptococcose

Patient âgé de 27 ans, admis aux urgences pour des céphalées chroniques. Examen clinique : patient conscient, raideur de la nuque, fièvre à 38°C, candidose buccale. Scanner cérébral : normal. La sérologie VIH et syphilitique (TPHA VDRL) sont positives dans le sang. Quel sont les diagnostics à évoquer ?

- A) La méningite tuberculeuse.
- B) La cryptococcose neuroméningée.
- C) Le lymphome cérébral.

- D) La toxoplasmose cérébrale.
- E) La neurosyphilis.

Q391. Cryptococcose

Dans la continuité du cas précédent, la ponction lombaire a retiré un liquide clair, en jet, 20 éléments, 70% de lymphocytes, une hypoglycorachie, une hyperproteinorachie et la coloration à l'encre de chine positive. Quel est le schéma thérapeutique qu'on doit prescrire au patient ?

- A) Céphalosporine de troisième génération.
- B) Amphotéricine B associé au Fluconazole.
- C) Cotrimoxazole.
- D) Antituberculeux.
- E) Pénicilline G.

Q392. Rage

Vous recevez aux urgences un patient de 25 ans, victime il y a 2 heures d'une morsure par un chien errant au niveau de la cuisse occasionnant une plaie superficielle. Votre conduite thérapeutique sera :

- A) Vaccination antitétanique.
- B) Immunoglobulines antirabiques.
- C) Traitement antiviral.
- D) Vaccination antirabique.
- E) Suture de la plaie.

Q393. Fièvre typhoïde

Patient âgée de 18 ans, sans notion de voyage récent, admis pour une diarrhée et des douleurs abdominales évoluant depuis 6 jours. L'examen clinique trouve un patient conscient, fébrile à 40°C, une langue chargée, une TA à 12/7 mmHg, une fréquence cardiaque à 60 battements /min et une splénomégalie. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Paludisme.
- B) Fièvre typhoïde.
- C) Infection urinaire.
- D) Méningite bactérienne.
- E) Brucellose.

Q394. Fièvre typhoïde

Dans la continuité du cas précédent, quel est le traitement qu'on doit prescrire au patient ?

- A) Gentamycine.
- B) Pénicilline A.
- C) Azithromycine.
- D) Ciprofloxacine.
- E) Métronidazole.

Q395. Infections à streptocoques

Enfant de 10 ans, ATCD d'angines mal traitées il y a 15 jours, admis pour des arthralgies inflammatoires des genoux et des coudes. Examen clinique : fièvre à 38°C, articulations rouges, chaudes et douloureuses. Bilan : hyperleucocytose à 15 000 (PNN à 12 000), VS à 80 min, CRP à 230 UI. L'échographie cardiaque : absence d'image de végétation. Quel est le premier diagnostic qu'on doit évoquer chez ce patient ?

- A) Polyarthrite rhumatoïde.
- B) Septicémie à staphylocoque.
- C) Angines streptococciques.
- D) Endocardite infectieuse.
- E) Rhumatisme articulaire aigu.

Q396. Infections à streptocoques

Dans la continuité du cas précédent, quel est le ou les traitements qu'on doit prescrire au patient ?

- A) Céphalosporines de troisième génération.
- B) Benzathine Pénicilline G (Extencilline).
- C) Acide acétylsalicylique.
- D) Ciprofloxacine.
- E) Corticoïdes.

Q397. Septicémies à staphylocoques

Quels sont les signes cliniques qui définissent le score Quick SOFA caractéristique du sepsis ?

- A) Hypotension artérielle systolique PAS ? 100 mmHg.
- B) Oligo-anurie.
- C) Tachycardie FC ? 22 cycles/min.
- D) Confusion.
- E) Ictère cutanéomuqueux.

Q398. Fièvre typhoïde

Les causes bactériennes des fièvres prolongées sont représentées par :

- A) Rougeole.
- B) Endocardite infectieuse.
- C) Tuberculose.
- D) Erysipèle.

E) Infections à germes intracellulaires.

Q399. Méningites infectieuses

Quels sont les contre-indications de la ponction lombaire ?

- A) Trouble de l'hémostase.
- B) Prise de contraste méningée à la TDM cérébrale.
- C) Signes d'engagement scannographiques.
- D) Infection cutanée en regard de la zone de ponction.
- E) Hémiplégie avec scanner cérébral normal.

Q400. Septicémies à staphylocoques

Les localisations pulmonaires des septicémies à staphylocoque :

- A) Sont fréquentes.
- B) Le pronostic est grave.
- C) Imposent une radiographie pulmonaire systématique.
- D) L'aspect bulleux est caractéristique.
- E) Peuvent être asymptomatiques.

Q401. Septicémies à staphylocoques

Le traitement de choix des bactériémies à staphylocoque méticillino-résistant est :

- A) Oxacilline.
- B) Gentamycine.
- C) Vancomycine + Aminoside.
- D) Céphalosporine de troisième génération.
- E) Ciprofloxacine.

Q402. Septicémies à staphylocoques

Les bactériémies communautaires à bacilles gram négatifs sont liées aux germes suivants :

- A) Pseudomonas aeruginosa.
- B) Escherichia Coli.
- C) Klebsielle.
- D) Salmonelle.
- E) Acinetobacter.

Q403. Infections à streptocoques

Quels sont les signes cliniques évocateurs de l'érysipèle ?

- A) Intertrigo-inter-orteil.
- B) Placard inflammatoire induré.
- C) Extension rapide.
- D) Limites nettes.
- E) Nécrose.

Q404. Tétanos

Quel est le signe le plus évocateur du tétanos ?

- A) Trouble de conscience.
- B) Agitation.
- C) Trismus.
- D) Crise convulsive.
- E) Raideur méningé.

Q405. Cryptococcose

L'Amphotéricine B (Fungizone®) est :

- A) Indiqué dans l'aspergillose.
- B) Néphrotoxique.
- C) Responsable des réactions d'hypersensibilité.
- D) La forme lipidique (Ambisome®) est mieux tolérée.
- E) Diffuse bien dans le LCR.

Q406. Infections liées aux tiques

Quels sont les signes cliniques de la fièvre boutonneuse méditerranéenne ?

- A) Erythème chronique migrant.
- B) Purpura dans les formes graves.
- C) Nécrose d'inoculation.
- D) Eruption cutanée respectant les paumes et les plantes.
- E) Lésions vésiculeuses.

RATTRAPAGE 2022

Q407. Toxoplasmose

Cas Clinique 1 : Madame Fatima Primigeste en 2ème semaine de grossesse, vous apporte les résultats de ses sérologies de la toxoplasmose. IgG anti toxoplasme = 1,3 UI/ml (ELISA, seuil de positivité 8). IgM anti toxoplasme = 0,4 UI/ml (ELISA, seuil de positivité = 0,65). Comment interprétez-vous les résultats de cette sérologie et Quel est votre attitude ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q408. Nématodoses digestives

Cas clinique 2 : Une fillette de 6 ans se plaint depuis 4 semaines de prurit anal à prédominance nocturne. Quel est le diagnostic le plus probable ? Quel est le mode de contamination de cette parasitose ? Quel examen prescrirez-vous en première intention pour confirmer le diagnostic ? Citez deux règles d'hygiène à conseiller à la maman pour éviter les récurrences ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q409. Plathelminthes

Cas clinique 3 : Un jeune garçon est amené à la consultation suite à la découverte dans sa culotte d'un fragment plat de 2 cm de long de couleur blanc nacré et mobile par reptation. Quel est le diagnostic le plus probable ? Quel est le mode de contamination de cette parasitose ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q410. Introduction à la parasitologie médicale

Qu'est-ce qu'un parasite opportuniste ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q411. Amoebose et amibes intestinales

Définir une amoebose (Amibiase).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q412. Amoebose et amibes intestinales

Concernant *Entamoeba histolytica*, cochez la réponse vraie :

- A) Est un Protozoaire flagellé.
- B) Est différencié microscopiquement d'*Entamoeba dispar*.
- C) Est différencié microscopiquement d'*Entamoeba coli*.
- D) Est strictement intraluminaire.
- E) Est responsable de lésions invasives par le biais de ses kystes.

Q413. Leishmaniose

Au Maroc la leishmaniose viscérale est due à :

- A) *Leishmania major*.
- B) *Leishmania infantum*.
- C) *Leishmania donovani*.
- D) *Leishmania tropica*.
- E) *Leishmania brasiliensis*.

Q414. Nématodoses digestives

Parmi les propositions suivantes une seule est spécifique de l'ascaridiose :

- A) Elle est due à *Taenia solium*.
- B) Elle s'accompagne d'un syndrome de Löffler en phase d'état.
- C) Elle peut se compliquer d'appendicite.
- D) Son agent responsable est un sporozoaire.

Q415. Méningites infectieuses

L'étude cytologique d'un prélèvement de liquide céphalo-rachidien, pratiqué chez un patient de 30 ans, montre : 2000 éléments/mm³ avec 80 % de polynucléaires et 20 % de lymphocytes, présence de rares diplocoques Gram négatif. La bactérie la plus probablement en cause est :

- A) *Pneumococcus*.
- B) *Haemophilus influenzae*.
- C) *Meningococcus*.
- D) *Staphylococcus aureus*.
- E) *Listeria monocytogenes*.

Q416. Méningites infectieuses

Concernant la méningo-encéphalite herpétique de l'adulte :

- A) Le scanner montre des lésions temporo-frontales.
- B) Elle s'associe habituellement à une éruption vésiculeuse cutanéo-muqueuse.
- C) Le risque de séquelles est exceptionnel.
- D) Elle est due essentiellement à Herpès simplex type 1.
- E) Elle est traitée par l'Acyclovir (Zovirax) par la voie veineuse.

Q417. Paludisme MI

Le paludisme peut être contracté par :

- A) Transfusion de dérivés sanguins.
- B) Transmission sexuelle.
- C) Transmission placentaire.
- D) Utilisation de seringues souillées.

E) Ingestion d'aliments parasités.

Q418. Tétanos

Retenez les propositions exactes concernant le tétanos :

- A) C'est une toxi-infection.
- B) La trachéotomie systématique.
- C) L'alimentation se fait par voie parentérale.
- D) le trismus est le signe cardinal de la maladie.
- E) Maladie immunisante.

Q419. Tétanos

Un patient de 50 ans qui ne se souvient pas de ses vaccinations antérieures contre le tétanos, s'est blessé le pied avec une arme.

Quelle prophylaxie spécifique doit être adoptée ?

- A) Antibiothérapie seule.
- B) Sérothérapie seule.
- C) Chimio prophylaxie seule.
- D) Vaccination seule.
- E) Sérothérapie et vaccination antitétanique.

Q420. Infections à streptocoques

Parmi les affections suivantes indiquez celles qui sont spécifiques du streptocoque ?

- A) Angine érythémateuse.
- B) Erysipèle.
- C) Impétigo.
- D) Scarlatine.
- E) Toutes les réponses suscitées.

Q421. Infections liées aux tiques

La fièvre boutonneuse méditerranéenne :

- A) Est transmise par morsure de mammifère.
- B) A pour agent étiologique Rickettsia conorii.
- C) Est diagnostiquée par la mise en évidence du germe sur les hémocultures.
- D) Est diagnostiquée par la sérologie en immunofluorescence.
- E) Nécessite un traitement par les bêta lactamines.

Q422. Infections liées aux tiques

Parmi les antibiotiques suivants, le ou lesquels peuvent être utilisés pour le traitement d'une fièvre boutonneuse méditerranéenne ?

- A) Pénicilline G.
- B) Gentamicine.
- C) Ofloxacine.
- D) Tétracycline.
- E) Rifampicine.

Q423. Méningites infectieuses

Quels sont les éléments caractéristiques de la méningite tuberculeuse ?

- A) Hyponatrémie.
- B) Strabisme convergent.
- C) Méningite purulente.
- D) Hypoglycorachie.
- E) Tuberculomes au scanner cérébral.

Q424. Infections à streptocoques

Quels sont les critères de diagnostic du rhumatisme articulaire aigu (RAA) ?

- A) Arthralgies inflammatoires.
- B) Endocardite.
- C) Hyperleucocytose.
- D) Elévation de la CRP.
- E) Purpura.

Q425. Septicémies à staphylocoques

Les septicémies à staphylocoque méticillino-sensible :

- A) Le point de départ est une thrombophlébite.
- B) Les métastases septiques sont rares.
- C) La porte d'entrée est cutanée.
- D) Le traitement repose sur la vancomycine.
- E) Peut se compliquer d'abcès pulmonaire avec niveau hydro-aérique.

Q426. Paludisme MI

Patient âgé de 45 ans, ingénieur de profession, revient d'un voyage du Niger il y a 8 jours et qui présente une fièvre et des vomissements. Quel est le premier diagnostic à évoquer chez ce patient ?

- A) Fièvre typhoïde.
- B) Hépatite virale A.
- C) Primo-infection à VIH.

- D) Tuberculose.
- E) Paludisme.

Q427. Paludisme MI

Patient âgé de 45 ans de retour du Niger avec fièvre. Parmi les bilans suivants, quels sont ceux à demander en urgence ?

- A) Radiographie du thorax.
- B) Frottis mince.
- C) Goutte épaisse.
- D) Hémoculture.
- E) Sérologie VIH.

Q428. Paludisme MI

Le bilan revient positif chez le voyageur du Niger, quel est le médicament qu'on doit prescrire au patient ?

- A) Ciprofloxacine.
- B) Extencilline.
- C) Pénicilline M.
- D) Cyclines.
- E) Artesunate.

Q429. Paludisme MI

L'évolution après deux jours d'hospitalisation du voyageur était marquée par l'installation d'un trouble de conscience avec un score de Glasgow à 8 /15. Quel est la complication à redouter chez ce patient ?

- A) Abscess cérébral.
- B) Méningite tuberculeuse.
- C) Choc septique.
- D) Méningite à cryptocoque.
- E) Accès pernicieux.

Q430. Méningites infectieuses

La méningite à méningocoque B, épidémique et contagieuse, rend obligatoire des mesures de prévention immédiates dans l'entourage du patient. Indiquez la bonne prescription :

- A) Pénicilline G 500 000 UI IM pendant 5 jours.
- B) Rifampicine 300 mg/j pendant 3 jours.
- C) Vaccination antiméningococcique.
- D) Gamma globulines 0,3 ml/kg IM, une seule injection.
- E) Désinfection rhinopharyngée par un antiseptique pendant 3 jours.

Q431. Infection à VIH

Parmi les infections suivantes quelles sont celles qui classent l'infection à VIH au stade Sida ?

- A) Zona.
- B) Herpès génital.
- C) Toxoplasmose cérébrale.
- D) Tuberculose.
- E) Rétinite à cytomégalovirus.

Q432. Infection à VIH

Quelles sont les indications du dépistage de l'infection à VIH ?

- A) Les accidents d'exposition au sang.
- B) La lymphopénie.
- C) La sérologie syphilitique positive.
- D) La tuberculose.
- E) La grossesse.

Q433. Accidents d'exposition au sang

Après un accident d'exposition au sang, il faut suivre les mesures suivantes :

- A) Désinfecter à l'eau de javel.
- B) La prophylaxie post exposition au VIH est toujours indiquée.
- C) Faire saigner la blessure.
- D) Faire la déclaration de l'accident.
- E) Vacciner contre l'hépatite virale B.

Q434. Accidents d'exposition au sang

Quels sont les facteurs qui augmentent le risque de transmission virale après un accident d'exposition au sang ?

- A) Personne source infectée par le VIH au stade Sida.
- B) Pique par une seringue abandonnée.
- C) Port de gant.
- D) Pique par une aiguille creuse.
- E) Personne source agitée.

Q435. Infection à VIH

Quel est le test qui permet de détecter le plus précocement la contamination par le VIH ?

- A) La PCR de l'ARN viral.
- B) Tests rapides (Tests d'immunofiltration).

- C) Détection de l'Antigène P24.
- D) La sérologie ELISA.
- E) Le western Blot.

Q436. Infections à streptocoques

L'érythème de la scarlatine est :

- A) Une éruption au niveau de la muqueuse linguale très caractéristique.
- B) Une nappe érythémateuse diffuse sans intervalle de peau saine.
- C) Respecte la face.
- D) Evolue vers la desquamation.
- E) Toutes les réponses sont justes.

Q437. Infections à streptocoques

L'érysipèle :

- A) Est dû au streptocoque du groupe A.
- B) A un début brutal marqué par de la fièvre.
- C) Est formé par une plaque rouge vif, chaude et douloureuse.
- D) Est bien limité.
- E) Le traitement repose sur la corticothérapie.

Q438. Infection à VIH

Patient âgé de 40 ans, admis aux urgences pour un trouble de conscience. Examen clinique : fièvre à 38°C, candidose buccale et hémiparésie droite. Scanner cérébral : hypodensité entourée d'une prise de contraste en anneau et oedème périlésionnel (image en cocarde). La sérologie VIH est positive. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) La méningite tuberculeuse.
- B) La cryptococcose neuroméningée.
- C) La neurosyphilis.
- D) La toxoplasmose cérébrale.
- E) La méningite à Pneumocoque.

Q439. Infection à VIH

Le traitement de la toxoplasmose cérébrale repose sur les molécules suivantes :

- A) Amphotéricine B.
- B) Céphalosporine de troisième génération.
- C) Cotrimoxazole.
- D) Pyriméthamine - sulfadiazine.
- E) Corticoïde IV (solumedrol).

Q440. Fièvre typhoïde

Patient âgé de 30 ans, admis aux urgences pour une diarrhée aiguë, des céphalées et une fièvre depuis 5 jours. Examen clinique : patient fébrile à 40°C, Fréquence cardiaque à 60 battements/min, langue saburrale et hépatomégalie. Bilan : échographie abdominale normale, GB à 3000 éléments (PNN à 1200 éléments). Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Pyélonéphrite aiguë.
- B) Méningite à méningocoque.
- C) Primo-infection à VIH.
- D) Fièvre typhoïde.
- E) Septicémie à staphylocoque.

Q441. Fièvre typhoïde

Quel est le bilan à faire pour confirmer le diagnostic de Fièvre typhoïde ?

- A) L'hémoculture.
- B) La goutte épaisse.
- C) L'examen cyto bactériologique des urines (ECBU).
- D) La sérologie VIH.
- E) La coproculture.

Q442. Fièvre typhoïde

Le résultat de ce bilan (typhoïde) est positif. Quel est le traitement qu'on doit prescrire au patient ?

- A) Traitement antituberculeux.
- B) Artesunate en IV.
- C) Ciprofloxacine.
- D) Fluconazole.
- E) Amphotéricine B.

Q443. Septicémies à staphylocoques

Quelles sont les localisations secondaires décrites dans les bactériémies à staphylocoque ?

- A) Arthrite septique.
- B) Pneumopathie bulleuse.
- C) Spondylodiscite.
- D) Ostéomyélite.
- E) Endocardite infectieuse.

Q444. Rage

Vous recevez aux urgences un patient âgé de 36 ans, victime d'une morsure par un chien errant au niveau du pied occasionnant une plaie superficielle. Votre conduite thérapeutique sera :

- A) Vaccination antirabique.
- B) Vaccination antitétanique.
- C) Amoxicilline.
- D) Immunoglobulines antirabiques.
- E) Suture de la plaie.

Q445. Infection à VIH

Patient âgé de 36 ans, séropositif pour le VIH, admis pour des lésions cutanées nodulaires, violacées, atteignant les membres et le voile du palais. Le résultat de la biopsie cutanée est en cours et le taux des CD4 est à 60 cellules/mm³. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Tuberculose cutanée.
- B) Syphilis cutanée.
- C) Furoncles.
- D) Sarcome de kaposi.
- E) Lésions herpétiques.

Q446. Fièvre typhoïde

La fièvre prolongée :

- A) Est défini par une fièvre supérieure à 38,3°C durant plus de 15 jours.
- B) La fièvre oscillante est caractéristique des septicémies.
- C) Est principalement d'origine tumorale.
- D) Les causes infectieuses sont dominées par l'endocardite infectieuse.
- E) Le bilan de première intention comprend l'échographie abdominale.

II. GRILLE DE CORRECTION

Q01: A	Q02: B	Q03: B	Q04: B	Q05: B
Q06: B	Q07: C	Q08: C	Q09: B, D	Q10: B
Q11: B	Q12: D	Q13: B	Q14: C	Q15: C
Q16: C	Q17: B	Q18: B	Q19: A	Q20: D
Q21: C	Q22: A	Q23: B	Q24: B	Q25: B
Q26: E	Q27: D	Q28: E	Q29: C	Q30: A
Q31: C, D, E	Q32: D	Q33: A	Q34: A, C, D	Q35: D
Q36: B	Q37: D	Q38: B, C	Q39: A, B, C, D	Q40: B, C, D
Q41: E	Q42: C	Q43: D	Q44: C, E	Q45: A, B, C, E
Q46: B	Q47: A, B, C, D	Q48: C	Q49: A, B, C, E	Q50: B, C, D
Q51: C	Q52: B	Q53: B	Q54: B	Q55: B
Q56: B	Q57: C	Q58: C	Q59: B, D	Q60: B
Q61: B	Q62: D	Q63: B	Q64: C	Q65: C
Q66: C	Q67: B	Q68: B	Q69: A	Q70: D
Q71: C	Q72: A	Q73: A, B	Q74: B	Q75: B
Q76: A	Q77: A	Q78: C	Q79: C	Q80: D
Q81: C	Q82: A, B	Q83: A, B, C, D	Q84: A	Q85: A, B, C
Q86: A, B	Q87: A, C	Q88: B	Q89: B	Q90: A, C, E
Q91: A, C	Q92: A, B	Q93: C	Q94: A, B, C, D, E	Q95: A, B, C, D, E
Q96: B	Q97: E	Q98: B, C	Q99: A, B, D	Q100: A, C
Q101: A, D, E	Q102: A, B, D, E	Q103: A	Q104: B, D, E	Q105: A, D
Q106: A, B, C	Q107: A, B, C, D	Q108: A, D, E	Q109: B, C	Q110: A, B, E
Q111: B, D, E	Q112: A, B, D, E	Q113: C	Q114: A, B, C	Q115: A
Q116: A, E	Q117: E	Q118: E	Q119: A, C	Q120: A, B, C, D, E
Q121: A, B, C, D, E	Q122: A, C, D, E	Q123: E	Q124: B, C, D	Q125: A, B, C, D, E
Q126: A, B, C, D, E	Q127: B	Q128: C	Q129: B, E	Q130: A
Q131: A	Q132: A, B, D	Q133: B, C	Q134: A, B, C, D	Q135: B
Q136: A	Q137: C	Q138: A, D	Q139: B	Q140: B
Q141: C	Q142: C	Q143: B	Q144: B	Q145: C, D
Q146: B	Q147: D	Q148: B	Q149: C	Q150: B
Q151: B	Q152: B	Q153: A	Q154: C	Q155: B
Q156: C	Q157: A	Q158: C	Q159: A	Q160: B
Q161: A	Q162: C	Q163: B	Q164: B	Q165: A
Q166: A	Q167: A	Q168: A	Q169: A	Q170: A
Q171: B	Q172: C	Q173: A	Q174: B	Q175: A, B, C, D
Q176: A, B	Q177: A, B, C, D	Q178: A, C, E	Q179: A, B, C, D	Q180: A, B, D, E
Q181: B	Q182: A	Q183: B, D, E	Q184: D	Q185: A, C

Q186: A, B	Q187: A, B, C, D	Q188: E	Q189: A, C	Q190: E
Q191: D	Q192: C, D	Q193: A, E	Q194: B, C, D	Q195: A
Q196: B	Q197: A	Q198: A, B	Q199: B	Q200: B
Q201: A	Q202: B	Q203: C	Q204: C	Q205: B
Q206: B	Q207: C	Q208: C	Q209: B	Q210: B
Q211: C	Q212: B	Q213: B	Q214: B	Q215: B
Q216: B	Q217: C	Q218: B	Q219: B	Q220: A
Q221: C	Q222: C	Q223: D	Q224: A	Q225: B, D, E
Q226: D	Q227: A, C	Q228: A, B	Q229: A	Q230: E
Q231: A, C	Q232: E	Q233: D	Q234: C, E	Q235: A, E
Q236: B, D	Q237: A	Q238: B	Q239: A	Q240: C, D
Q241: A	Q242: A	Q243: A	Q244: A	Q245: A
Q246: A	Q247: B	Q248: B	Q249: A	Q250: B
Q251: C	Q252: C	Q253: B	Q254: B	Q255: C
Q256: C	Q257: A, B	Q258: B	Q259: C	Q260: B
Q261: B	Q262: B	Q263: B	Q264: B	Q265: C
Q266: B	Q267: B	Q268: A	Q269: C	Q270: C
Q271: D	Q272: A	Q273: B, D, E	Q274: D	Q275: A, B, C
Q276: A, B	Q277: A	Q278: E	Q279: A, C, D	Q280: A
Q281: D	Q282: C, D, E	Q283: A, E	Q284: B, C, D	Q285: A
Q286: B	Q287: A	Q288: A, C	Q289: A	Q290: A
Q291: A	Q292: A	Q293: A	Q294: A	Q295: A
Q296: A	Q297: C	Q298: D, E	Q299: A, B, E	Q300: E
Q301: B	Q302: D, E	Q303: A, B, D, E	Q304: C	Q305: A
Q306: C, D, E	Q307: B, D, E	Q308: A, B, C	Q309: D	Q310: A, B, C
Q311: C	Q312: B	Q313: A, C, D, E	Q314: B	Q315: B, C, D
Q316: B, D, E	Q317: A, C, D, E	Q318: C, D, E	Q319: A, B, C, D	Q320: B, C, E
Q321: A	Q322: A	Q323: A	Q324: A	Q325: A
Q326: A	Q327: A	Q328: A	Q329: A	Q330: A
Q331: A	Q332: A	Q333: A	Q334: A	Q335: A
Q336: A	Q337: A	Q338: A	Q339: A	Q340: C, E
Q341: C, D	Q342: A, B, E	Q343: A, E	Q344: A, B, C, D	Q345: D
Q346: B, D	Q347: C, D, E	Q348: A, B, D	Q349: B	Q350: A, B, D, E
Q351: A, B, C	Q352: C, D	Q353: A, C, D, E	Q354: A, C, D, E	Q355: B, D, E
Q356: A, D	Q357: B, C, E	Q358: B	Q359: C, E	Q360: A
Q361: A	Q362: A	Q363: A	Q364: A	Q365: A
Q366: A	Q367: A	Q368: A	Q369: A	Q370: A
Q371: A	Q372: A	Q373: A, B, C	Q374: A	Q375: A
Q376: A	Q377: A	Q378: E	Q379: A	Q380: B, C

Q381: B	Q382: A, D, E	Q383: B, D, E	Q384: B	Q385: E
Q386: B	Q387: B, C	Q388: C, D	Q389: A, B, C, E	Q390: A, B, E
Q391: B	Q392: A, D	Q393: B	Q394: D	Q395: E
Q396: A, D	Q397: A, C, D	Q398: B, C, E	Q399: A, C, D	Q400: A, B, C, D, E
Q401: C	Q402: B, C, D	Q403: A, B, C, D	Q404: C	Q405: A, B, C, D, E
Q406: B, C	Q407: A	Q408: A	Q409: A	Q410: A
Q411: A	Q412: C	Q413: B	Q414: C	Q415: C
Q416: A, D, E	Q417: A, C, D	Q418: A, C, D	Q419: E	Q420: E
Q421: B, D	Q422: D	Q423: A, B, D, E	Q424: A, B, D	Q425: A, C, E
Q426: E	Q427: B, C	Q428: E	Q429: E	Q430: B, C
Q431: C, D, E	Q432: A, B, C, D, E	Q433: A, D, E	Q434: A, D, E	Q435: A
Q436: B, C, D	Q437: A, B, C, D	Q438: D	Q439: C, D, E	Q440: D
Q441: A	Q442: C	Q443: A, B, C, D, E	Q444: A, B, C	Q445: D
Q446: B, D, E				